**Ministério do Planejamento e Orçamento**
**Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID**
**Secretaria Executiva da COFIEX**
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

# CARTA CONSULTA

## Programa de Fortalecimento do SUS no Estado da Bahia - PROSUS II

**Nº Carta Consulta: 60820**
**Processo: 12120.100364/2021-44**
**Mutuário: Estado da Bahia**
**Tipo de Operação: Operação de crédito externo**
**Data de Recebimento: 3 de Agosto de 2021**

**Fontes Internas:**
Contrapartida Financeira: US$ 37.500.000,00
**Fontes Externas:**
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID: US$ 150.000.000,00

# Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA ..... 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO ..... 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE ..... 11
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO ..... 14
2. PROJETO ..... 15
2.1. TÍTULO ..... 15
2.2. TÍTULO ABREVIADO ..... 15
2.3. MUTUÁRIO ..... 15
2.4. TIPO OPERACAO ..... 15
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS ..... 15
2.6. PROJETO/INDICADORES ..... 16
2.7. PROJETO/COMPONENTES ..... 18
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS ..... 24
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA ..... 25
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO ..... 25
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO ..... 27
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO ..... 27
3. FINANCIAMENTO ..... 27
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE ..... 27
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS ..... 27
4. EXECUÇÃO ..... 27
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL ..... 27
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES ..... 28
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO ..... 28
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA ..... 28
5. RISCOS ..... 32
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS ..... 32
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES ..... 32
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES ..... 32
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS ..... 33
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL ..... 33
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS ..... 33
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN ..... 33

# 1. Marco de Referência

## 1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

O estado da Bahia segue a tendência de outros estados brasileiros e países da América Latina, onde enfrenta um importante período de transição demográfica e epidemiológica que, junto com o seu crescimento populacional, aumentam a demanda do seu sistema único de saúde (SUS- BA). A tripla carga de doenças, ou seja, a prevalência de doenças crônicas não-transmissíveis na população, junto às doenças infectocontagiosas reemergentes, e com um aumento da morbimortalidade por causas externas fazem parte da atual situação epidemiológica do estado.

A conjunção do aumento da pressão sofrida pelo sistema de saúde, especialmente neste momento da pandemia da COVID-19, elevou os gastos públicos nessa área, tornando necessária não apenas a ampliação da oferta de serviços, mas também a otimização dos recursos atuais.

Dessa forma, o Programa de Fortalecimento do SUS no Estado da Bahia (PROSUS II) pretende expandir as ações do PROSUS I e investir na melhoria dos processos e da gestão do sistema de saúde, através do investimento na informatização e automatização da gestão dos hospitais do estado, da gestão dos recursos humanos de saúde e da ampliação da rede de serviços de alta, média e baixa complexidade no restante do estado.

No que se refere à melhoria dos processos e da gestão, destaca-se o necessário investimento em um novo parque tecnológico que suporte a modernização. Além dos equipamentos de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) previstos, busca-se a ampliação da implantação de prontuários eletrônicos do cidadão e de teleatendimento, telediagnóstico e teleconsultorias que possibilitará a otimização dos serviços, seus referidos gastos e melhores resultados de saúde para a população.

Em relação ao aumento na oferta de serviços, considerando-se o perfil demográfico e epidemiológico do estado, este programa pretende realizar investimentos em infraestrutura e aquisição de equipamentos para Unidades Básicas de Saúde (UBS), Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Centros de Reabilitação (CER), Policlínicas e leitos de UTI para os hospitais da rede. Além disso, visa apoiar os serviços de apoio diagnóstico como o Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN), Rede de Frios e outros serviços itinerantes como Hemóveis e Carretas com Mamógrafos.

Por fim, é imprescindível capacitar os gestores e profissionais de saúde em um modelo formativo de educação permanente ágil e eficiente.

A seguir, serão apresentados um diagnóstico sociodemográfico e um diagnóstico epidemiológico do estado da Bahia, os principais problemas enfrentados pelo sistema de saúde do estado que o corrente Programa pretende contribuir com a resolução. Ao final desta seção, trazemos a nova realidade imposta a partir da Pandemia de SARS-Cov-2 e a atual capacidade instalada do Sistema Único de Saúde da Bahia

Diagnóstico sociodemográfico

A Bahia é o quinto estado em extensão territorial, com o quarto maior contingente populacional do país. A sua população em 2018 foi estimada pelo IBGE em 14.812.617 habitantes, 72,1% deles residentes em zonas urbanas (IBGE, 2018).

De 1980 e 2015, a população do estado cresceu 60,8%. Porém, as últimas décadas apresentaram uma diminuição do ritmo de crescimento populacional. Entre os anos de 1991 e 2000, houve um crescimento populacional médio de 1,09% ao ano. Já entre 2000 e 2010, essa taxa caiu para 0,72% ao ano (SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, 2016). As projeções apontam para uma redução ainda mais acentuada em 2018, com 0,41 e de apenas 0,10 em 2030 (PES 2020-2021, SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, 2019).

Além dessa redução na taxa de crescimento populacional, outros fatores como a redução da mortalidade infantil, o aumento da expectativa de vida e a diminuição das taxas de fecundidade, produziram impacto importante na estrutura etária da população - processo denominado de transição demográfica.

No estado, a taxa de fecundidade decresceu em 32,8% no período de 2000 a 2018. Nas últimas décadas, o número de filhos por mulher passou de 2,49 para 1,67, sendo a média da Bahia (1,99) semelhante à do país, de 1,94 filhos por mulher. Quando se compara os 3,6 filhos/mulher registrado nas décadas de 1980/1991, esta redução foi de 53,6%. A tendência decrescente na taxa de fecundidade encontrada para o estado acompanha os índices registrados para o país e suas regiões geográficas (PES 2020-2021, SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, 2019).

Ao analisar as mudanças na estrutura etária da população entre os anos 1980 e 2018, observa-se um decréscimo de 0,5% entre os jovens com menos de vinte anos de idade. Em contrapartida, verifica-se uma acentuada elevação nas faixas etárias dos grupos populacionais com vinte anos e mais, principalmente entre os idosos com 60 anos e mais, cujo aumento foi 164, 9% (PES 2020-2021, SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, 2019). A maioria da população está na faixa etária de 20 a 50 anos, porém a população está envelhecendo. O envelhecimento populacional tem acarretado transformações na incidência e prevalência das doenças, bem como alavancado os índices de óbitos causados pelas Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT). O que acarreta na necessidade de políticas públicas integradas para a abordagem do problema das doenças crônicas nos idosos, um desafio para os sistemas de saúde em que tais sujeitos estão inseridos.

Dos 417 municípios do estado, 57% possui menos do que vinte mil habitantes. O Índice de Desenvolvimento Humano do estado foi considerado médio (0,666) no estudo realizado em 2010 pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) (PES 2020-2021, SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, 2019).

Diagnóstico epidemiológico

Perfil de mortalidade

O perfil de mortalidade baiano é característico de populações que atravessaram a transição epidemiológica, com a redução das mortes por doenças infectocontagiosas e o aumento relativo das mortes por doenças crônico-degenerativas. Além disso, há o aumento das mortes por causas externas e a coexistência de óbitos por doenças infectocontagiosas, principalmente nas populações mais vulneráveis, caracterizando um perfil com uma tripla carga de doenças.

As doenças crônicas não transmissíveis coexistem com desafios históricos como a persistência de doenças associadas à miséria e exclusão social, a exemplo da tuberculose e a hanseníase. Exigindo contínuas inovações dos modelos de vigilância; demandando transformações nas respostas sociais; expressas na forma como o sistema de saúde se organiza para ofertar serviços. Que ocorrem em conjunto com outras transformações demográficas, sociais e econômicas.

Desconsiderando-se os óbitos por causas mal definidas, em todos os anos entre 2009 e 2017, as doenças do aparelho circulatório foram as principais causas de morte no estado, correspondendo a um percentil entre 23,3% e 24,9% dos óbitos (dependendo do ano considerado). Já as causas externas foram a segunda causa de morte, oscilando entre 14,7% e 16,5%. Em terceiro lugar figuram as neoplasias, com uma tendência de crescimento no período, passando de 11,9% a 13,8%. A seguir, aparecem as doenças do aparelho respiratório, com uma estabilidade no período, oscilando entre 7,2% e 8,3%. Ocupando o quinto lugar das principais causas de óbito, estão as doenças endócrinas, com um discreto aumento de 7,1% a 7,8% (Gráfico 1 - Anexo 4).

Há que se destacar que no período houve uma melhora na investigação das causas de óbito. Em 2009, 13,6% dos óbitos foram por causas mal definidas, proporção que sofreu uma redução discreta, indo a 12,6% no final do período.

Dentre as doenças do aparelho circulatório, as doenças isquêmicas do coração (incluindo o infarto agudo do miocárdio) e as doenças cerebrovasculares apresentaram uma elevação de suas taxas de mortalidade, indicando um maior risco de morte por essas doenças ( Gráfico 2 - Anexo 4), principalmente após os 50 anos de idade.

Em 2017, as doenças cerebrovasculares apresentaram uma taxa de mortalidade de 44,7 óbitos por 100 mil habitantes. As doenças isquêmicas do coração apresentaram, nesse mesmo ano, uma taxa de 39,0 por 100 mil habitantes.

Em relação às causas externas, observou-se um aumento considerável do risco de morte por homicídios e por acidentes de trânsito. De 2009 a 2017, a taxa de mortalidade por homicídios passou de 36,9 óbitos por 100 mil habitantes para 44,9 ?um aumento de 12,5%. Já os acidentes de trânsito passaram de 13,2 para 15,6 óbitos por 100 mil habitantes, um aumento de 18% (Gráfico 3 - Anexo 4).

Desagregando-se os óbitos por acidentes de trânsito, temos um aumento do risco de morte por acidentes de motocicletas que passou de 0,7 óbitos por 100 mil habitantes em 2000, para 4,6 em 2017, um crescimento de 557% (PES 2020-2021, SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, 2019).

Quantos aos homicídios, o meio predominante utilizado pelos agressores foram as armas de fogo, a taxa de mortalidade por homicídios por armas de fogo alcançou 35,4 óbitos por 100.000 habitantes no ano de 2017, o que representou um crescimento de 18,4%, em relação a 2009, quando esta taxa foi de 29,9 óbitos por 100.000 habitantes (PES 2020-2021, SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, 2019).

Como ressaltado anteriormente, as neoplasias foram a terceira principal causa de morte no período. O câncer de mama, na população de mulheres, além de ser o mais frequente é o que apresenta o maior risco de morte. Em 2017, esta neoplasia apresentou a maior taxa no período, com risco de 12,7 óbitos por 100.000 mulheres. Para os homens, o câncer com o maior risco de morte foi o de próstata, alcançando em 2017 a taxa de 17,5 óbitos por 100.000 homens (PES 2020-2021, SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, 2019).

Internações hospitalares

Excluindo-se as internações relacionadas à gravidez, parto e puerpério, de 2009 a 2017, as doenças do aparelho respiratório foram as principais causas de internação na Bahia, correspondendo a 15,7% das internações em 2009 e 10,4% em 2017. No segundo lugar, ficaram as doenças infecciosas e parasitárias, responsáveis por 14,3% das internações em 2009 e 8,4% em 2017. A seguir, temos as doenças do aparelho digestivo e as doenças do aparelho circulatório com percentis de internação muito próximos. Em 2009, as doenças do aparelho digestivos eram responsáveis por 8,7% das internações, passando a 9,8% em 2017. Já as doenças do aparelho circulatório, eram responsáveis por 8,1% das internações em 2009, passando a 8,4% em 2017. Por fim, aparecem as causas externas, com 5,9% das internações em 2009 e 9,0% das internações em 2017; e, as internações por neoplasia com 4,0% em 2009 e 6,0% em 2017 (Gráfico 4 - Anexo 4).

Entre os menores de um ano, as principais causas de internação são as afecções originadas no período perinatal, as doenças do aparelho respiratório e as doenças infecciosas e parasitárias. Na faixa etária dos 1 aos 9 anos, as doenças do aparelho respiratório e as doenças infeciosas e parasitárias continuam sendo as principais causas de internação, seguida das doenças do aparelho digestivo. (Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), acessado em 07.06.21).

Entre os adultos ate 49 anos do sexo masculino, as principais causas de internação, de 2009 a 2017, foram as causas externas. No grupo entre 50 e 59 anos, as doenças do aparelho circulatório e digestivo são as principais responsáveis pelas internações, entretanto as causas externas figuram como terceira principal causa nesse grupo etário (Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), acessado em 07.06.21).

A análise das internações no sexo feminino revela que as principais causas na faixa etária de 20 a 49 foram as doenças do aparelho geniturinário, digestivo e as neoplasias. Ja entre mulheres de 50 a 59 anos, as doenças do aparelho circulatório ocupam a primeira causa de internações, seguida das doenças do aparelho digestivo e neoplasias, em terceiro lugar (Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), acessado em 07.06.21).

Para a faixa etária a partir dos 60 anos, as doenças do aparelho circulatório e as doenças do aparelho respiratório são as principais causas de internação para ambos os sexos (Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), acessado em 07.06.21).

Doenças redutíveis por imunização

A maioria das doenças redutíveis por imunização observaram uma diminuição de sua incidência, com exceção da hepatite de tipo B que registrou um aumento de 88,7%. Tal aumento pode ser o reflexo de um maior acesso ao diagnóstico através de exames sorológicos específicos, mas não exclui a possibilidade de um aumento da transmissão sexual (SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, 2016).

HIV/Aids e Sífilis Congênita

No que diz respeito a Aids e ao HIV, foram notificados, no período de 2009 a 2018, 18.287 casos de aids e 15.567 casos de HIV. A taxa de detecção da aids (por 100 mil habitantes), no mesmo período, apresentou decréscimo, sobretudo a partir de 2011, com apenas 13,7 casos abaixo da taxa nacional (22 por 100 mil habitantes). A partir de 2014, observa-se um aumento da incidência dos casos de HIV, ano que se tornou obrigatória a notificação dos casos confirmados. Destaca-se que em 2013 foi implementado o tratamento para todas as Pessoas Vivendo com HIV (PVHIV), independentemente da carga viral, o que tem contribuído para a redução dos casos de aids no estado (PES 2020-2021, SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, 2019).

A sífilis congênita (SC) é uma doença de elevada magnitude e transcendência, passível de controle desde que as mulheres com sífilis sejam diagnosticadas e tratadas adequadamente durante a gestação. A prevenção da transmissão vertical da sífilis é uma prioridade da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, em parceria com Ministério da Saúde (MS), em observância às orientações da Organização Pan Americana da Saúde (OPAS) e da Organização Mundial de Saúde (OMS), para atingir a taxa de incidência de sífilis congênita menor ou igual a 0,5 caso por 1.000 nascidos vivos (PES 2020-2021, SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, 2019).

De 2009 a 2018, a taxa de incidência de sífilis congênita na população menor de um ano, variou de 1,2 casos/1000 nascidos vivos em 2009 a 6,6 casos/1000 nascidos vivos em 2018, apresentando crescimento semelhante ao observado no país (PES 2020-2021, SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, 2019).

Concernente a mortalidade, na série histórica de 2009 a 2018, registrou-se 81 óbitos por SC em menores de 1 ano de idade de residentes na Bahia. O coeficiente de mortalidade variou de 0,5/100.000 nascidos vivos em 2010 a 8,3 óbitos/100.000 nascidos vivos em 2014, quando apresentou o maior coeficiente, cenário este de curva ascendente semelhante ao do Brasil (PES 2020-2021, SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, 2019).

Doenças de transmissão vetorial

As doenças de transmissão vetorial têm apresentado perfil de difícil controle no estado da Bahia, sendo as mesmas responsáveis na última década pela elevada morbimortalidade e sobrecarga nos sistemas de saúde. O fortalecimento de estratégias que colaborem com a integração entre as vigilâncias e rede assistencial torna-se imprescindível para desenvolvimento de ações articuladas e coordenadas direcionadas à prevenção e controle dos agravos relacionados à transmissão vetorial, incluindo o uso de agrotóxico em ações de saúde pública para combate ao vetor da dengue. Destaca-se a importância da atenção básica/ primária em saúde, tendo em vista o desenvolvimento de ações de promoção, prevenção e controle da doença, pelas equipes de saúde da família, agentes de saúde e os agentes de endemias, no território que atuam. A dengue é a mais importante arbovirose que afeta o homem. Na Bahia, os anos de 2009, 2013 e 2016 foram os que mais notificaram número de casos. Em 2009, foi registrada a maior epidemia desde a reintrodução da doença no estado, ocorrendo 96.651 casos notificados com coeficiente de incidência (CI) de 660,30/100 mil habitantes. Nos dois últimos anos da série histórica, 2017 e 2018, o estado apresentou redução dos coeficientes de incidência, respectivamente, 64,06 e 63,12/100 mil habitantes (PES 2020-2021, SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, 2019).

Outra arbovirose de relevância epidemiológica diz respeito à chikungunya (CHIKV). Em 2017, foram notificados 11.135 casos de Chikungunya, no estado da Bahia, ao passo que em 2018 foram 4.368, ocorrendo uma redução de 154,9% dos casos notificados. Com relação a faixa etária e sexo, o ano de 2017 apresentou comportamento semelhante ao ano de 2018. Neste último, a faixa etária mais atingida foi de 30 a 39 anos (858 casos/100.000 habitantes), correspondendo a 19,6% dos casos, seguida pelas faixas de 20 a 29 anos ( 761 casos/100.000 habitantes) com 17,2% e de 40 a 49 anos (654 casos/100.000 habitantes), representando 14,9% das notificações. Do total de casos notificados, 62,4% são do sexo feminino. Sobre a mortalidade, no período de 2014 a 2017, foram confirmados 15 óbitos por chikungunya. Os anos com o maior registro foram 2015 (6 casos) e 2016 (5 casos) (PES 2020-2021, SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, 2019).

Quanto ao vírus Zika, no período de 2015 a 2018, foram registrados 97.893 casos suspeitos de Zika, dos quais 58,9% concentraram-se no ano de 2016, com coeficiente de incidência (CI) de 379,21 casos/100 mil habitantes, sendo esse o ano mais epidêmico da doença. A partir de 2017, observou-se decréscimo no número de casos e no coeficiente de incidência, ratificando a característica cíclica da arbovirose. Em 2018, 67,2% das notificações foram de pessoas do sexo feminino, e do total de notificações para o mesmo período, 39,1% correspondem a faixa etária de 20 a 39 anos. Esse dado é de fundamental importância para saúde pública, visto que a faixa etária mais acometida foi a de população economicamente ativa e de mulher em idade fértil, fator que predispõe ao aumento de casos em gestantes e , consequentemente, aumento de registro de casos de microcefalia (PES 2020-2021, SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, 2019).

Com relação às complicações relacionadas à infecção pelo vírus Zika durante a gestação - microcefalia e Síndrome Congênita do Zika vírus - SCZv - no acumulado de 2015 a 2018, constam no Registro de Emergência em Saúde Pública notificações de casos de pacientes residentes em 252 municípios do estado, atingindo todas as Macrorregiões de Saúde, totalizando 1.885 casos, destes, 29,2% com confirmação diagnóstica. O maior número de casos notificados tem como residência municípios da Macrorregião Leste (58,5%), seguida da Centro-Leste (9,7%) (PES 2020-2021, SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, 2019).

Mortalidade materna

No estado da Bahia, a razão de mortalidade materna (por 100.000 nascidos vivos) passou de 91,6 óbitos em 2009, para 65,6 óbitos em 2017 (-28,5%). A razão de mortalidade materna, no estado da Bahia, ainda está aquém do esperado, considerando que a Organização Mundial da Saúde (OMS) estabelece como aceitável a razão de mortalidade materna (RMM) de até 20 óbitos por 100.000 nascidos vivos ( PES 2020-2021, SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, 2019).

A despeito da melhoria da cobertura de cuidados básicos em saúde e a redução da mortalidade materna, muitos desafios ainda se apresentam. Mortes maternas aquém do esperado refletem desigualdades no acesso aos serviços de saúde. Cuidados antes, durante e após o parto podem salvar a vida de mulheres e recém-nascidos.

Quanto à mortalidade segundo o tipo e principais causas, a análise da série histórica demonstrou que em todos os anos houve o predomínio das causas diretas, com destaque para as eclâmpsias e infecções puerperais, quando comparadas com as indiretas, principalmente a Aids e as doenças do aparelho circulatório. Nas causas diretas, notou-se que houve variações entre os anos, sendo a maior RMM em 2014 (52,3) e a menor em 2016 (39,0). Quanto as causas indiretas, estas apresentaram tendência de queda no período analisado, reduzindo 53,7% de 2009 para 2017 (PES 2020-2021, SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, 2019).

O novo contexto a partir da Pandemia de SARS-Cov-2

Em 11 de Março de 2020 foi anunciada pelo diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, em Genebra, reconheceu que o Novo Coronavírus tinha proporções Pandêmicas. Considerando o cenário mundial do novo coronavírus (COVID-19), em que foi detectado inicialmente na China em 31 de dezembro de 2019, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia iniciou o processo de articulação das ações de vigilância em saúde e organização da rede de atenção desde janeiro de 2020, visando preparar resposta coordenada para enfrentamento da possível ocorrência de casos na Bahia. Desde esta data, vimos os números avançarem e acometerem milhões de pessoas (06/06/2021), com uma perspectiva mórbida, que levou-nos a refletir sobre nossos hábitos, nossas relações e formas de assistir as pessoas.

Na Figura 1 (Anexo 4) que segue, podemos ver um resumo do que chegamos até a data de 7 de outubro de 2021 e na Figura 2 (Anexo 4) subsequente, o seu avanço semana a semana, desde o primeiro caso detectado em 06 de março de 2020.

No mapa (Anexo 4) podemos ver a disseminação do Vírus SARS-Cov-2, em uma distribuição espacial no Estado da Bahia.

O número total de óbitos por Covid-19 na Bahia desde o início da pandemia é de 26.881 (04/10/2021), representando uma letalidade de 2,18%. Dentre os óbitos, 55,72% ocorreram no sexo masculino e 44,28% no sexo feminino. O percentual de casos com comorbidade foi de 59,55%, com maior percentual de doenças cardíacas e crônicas (72,20%). Ao todo 1.235.369 foram acometidas pela COVID-19, sendo que segundo a OMS, 80% dos pacientes com COVID-19 apresentam sintomas leves e sem complicações, 15% evoluem para hospitalização que necessita de oxigenoterapia e 5% precisam ser atendidos em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e, nesta perspectiva, dos que forem hospitalizados necessitarão de acompanhamento com exames complementares e avaliação especializada, após alta. Já àqueles que necessitaram de atendimento em Unidades de Terapia Intensiva, necessitarão além dos cuidados já citados, de reabilitação.

Segundo a OMS, uma em cada 10 pessoas tem sequelas três meses após contrair novo coronavírus (OMS, 2021). A infecção parece estar associada ao Acidente Vascular Encefálico (AVE) em número significativo de casos e o impacto da pandemia na prevenção e tratamento de fatores de risco pode elevar a incidência do evento (CRUZ NETO et al, 2021; LOGROSCINO, BEGHI, 2021.

A partir deste novo contexto, imposto pela Pandemia da COVID19, o Governo do Estado precisou direcionar prioritariamente recursos para responder a situação de emergência de saúde, dentre eles, abertura de leitos de UTI, abertura de Hospitais para atendimento exclusivo ao COVID19, ampliação do Laboratório Central do Estado - LACEN, contratação de Unidades Móveis de porte avançado, ampliação do serviço de UTI aérea, entre outros.

Como o vírus possui um potencial excepcionalmente alto de disseminação, o contato com pacientes e o manuseio laboratorial seguro das amostras se fez necessário. Os laboratórios necessitaram se adequar na mesma velocidade da pandemia para atender com segurança à crescente demanda pelos testes diagnósticos. Ao final de 2020 o LACEN ampliou a sua capacidade instalada para um número de 2.008.440 análises realizadas, no entanto o Laboratório Central ainda não possui creditação NB3. Uma unidade de Nível de Biossegurança 3 ( NB3) consiste numa área especial instalada e equipada para o desenvolvimento e execução de estudos relacionados ao diagnóstico e a detecção de agentes de alto risco de contaminação para humanos. Entre os procedimentos de segurança exigidos para um laboratório com a certificação NB3 estão: controles de engenharia, equipamentos de proteção individuais, integridade do estabelecimento e do sistema, protocolo de operação e procedimento, e controles administrativos. São procedimentos que minimizam os riscos biológicos de infecção e contaminação aos seres humanos e ao meio ambiente.

Além disso, diante do atual cenário epidemiológico se faz necessário a descentralização do diagnóstico, para intensificação da Vigilância de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), e um melhor monitoramento dos casos. A emissão de alertas sobre a situação epidemiológica das diversas regiões de saúde do estado com orientações para a preparação de respostas e medidas de prevenção e controle das infecções humanas pelo vírus SARS-COV-2, em tempo oportuno, pode evitar internações e mortes.

Além destas estruturas e ações, também foi muito importante as ofertas à distância voltadas para trabalhadores e gestores, bem como a ampliação da Telessaúde, este último ficando como um legado para a Saúde e uma perspectiva de solidificação de uma estratégia inovadora para garantir assistência de forma segura, com resolutividade, ampliação do acesso e eficiente.

Telessaúde

O Telessaúde na Bahia ganhou uma perspectiva maior com a Pandemia, que explicitou a necessidade de atendimento especializado à distância, bem como capacitações (Web palestras, Video Aulas) e telediagnóstico. Na Bahia, o Telessaúde faz parte da Estrutura da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, o que possibilitou uma articulação com todos os Municípios e instituições de ensino de forma coordenada. Com isto, pactuou-se na Comissão Intergestora Bipartite, composta por Gestores Municipais e Gestores Estaduais, ofertas de Telediagnóstico (TeleECG e TeleDermatologia), bem como a adequação de acesso a serviços especializados a partir da Plataforma do Telessaúde Bahia. Isto propiciou com que usuários pudessem realizar exames de ECG e avaliação Dermatológicas na Atenção Primária à Saúde - APS, sem necessitar realizar agendamento em outros serviços especializados, o que fez com que ocorresse uma maior resolutividade, redução de encaminhamentos, menor deslocamento dos usuários, bem como redução de custos. Cabe salientar que atualmente temos 145 (cento e quarenta e cinco) Municípios que fazem uso deste serviço e temos a necessidade expandir para os 417, visto os benefícios para o serviço, para o usuário e para as finanças do Município.

No que tange a qualificação da assistência, o Telessaúde Bahia oferece teleconsultoria para os trabalhadores da APS a fim de subsidiar com conhecimentos baseados em evidências científicas para adequar condutas e diagnósticos. E quando necessário, as solicitações para atendimento especializado do Centro de Diabetes e Endocrinologia da Bahia - CEDEBA, podem ser realizadas pela plataforma do Telessaúde. Isto faz com que o Médico assistente da APS possa tirar suas dúvidas e encaminhar para o serviço sem a necessidade do usuário ter que pegar fila para agendar, sendo tudo discutido e registrado via Plataforma do Telessaúde, envolvendo apenas Médico assistente da APS e Médico Especialista do CEDEBA. E, esta experiência necessita ser ampliada para outros ambulatórios especializados e serviços. Desta forma, reduziremos encaminhamentos desnecessários, estabeleceremos protocolos de acesso, reduziremos fila, tornaremos a APS mais resolutiva e o tempo de espera para atendimento especializado reduzido, como já pudemos comprovar com a experiência do CEDEBA, bem como a experiência de outros estados que utilizam o Telessaúde como regulador das demandas ambulatoriais.

A Rede de Serviços do SUS Bahia e seus principais desafios

O Sistema Único de Saúde é reconhecido como uma grande conquista da população brasileira por ser uma política pública de saúde que garante acesso universal, integral e equânime, considerando as particularidades de indivíduos e suas populações. Seus princípios organizativos são a descentralização dos serviços; a regionalização e hierarquização da rede; e a participação social, que representam a forma de organização e operacionalização do sistema.

Dessa forma, o Sistema Único de Saúde do estado da Bahia se caracteriza como exemplo no país por prover acesso a serviços de saúde em um dos maiores estados em extensão territorial, com uma população de mais de 14 milhões de habitantes (7,1 % do país).

De acordo com a divisão político-administrativa, abrange 417 municípios, tendo como capital a cidade de Salvador, situada na macrorregião Leste e que representa 19,3% do total de habitantes do estado. Sua divisão na área da saúde se dá por meio de 28 regiões de saúde, que se aglutinam em 9 macrorregiões, também conhecidas como Núcleos Regionais de Saúde, conformando o desenho territorial resultante do Plano Diretor de Regionalização-PDR.

Em relação à assistência, cabe à Secretaria Estadual da Saúde da Bahia (SESAB) a oferta de atendimento de baixa, média e alta complexidade, ou seja, assistência envolvendo ações como cuidados de saúde primários, diagnósticos, tratamentos clínicos e tratamentos cirúrgicos, reabilitação, acompanhamento pré e pós-operatório, oferta de imunobiológicos e Unidades de Terapia Intensiva ( UTI).

Nesse sentido, a SESAB possui uma rede de unidades de saúde que envolve Hospitais, Maternidades, Unidades de Pronto Atendimento 24h e de Emergência e Centros de Referência. No total, a Rede SESAB conta com 54 unidades de saúde de alta e média complexidade, distribuídas em toda a Bahia. São 13 Hospitais na capital, 23 Hospitais no interior e 21 Policlínicas espalhadas pelo território baiano.

Em relação aos leitos de UTI no estado, no contexto da pandemia, observou-se a necessidade de ampliação da rede que já era reprimida para além da COVID-19.

As Unidades Básicas de Saúde, assim como as ações de Atenção Básica, são de responsabilidade dos municípios. Estão entre elas Postos de Saúde, Centros de Atenção Psicossocial, Unidades de Saúde da Família e ações de promoção da saúde mental e prevenção de doenças. Em todo o estado, são 3.693 Unidades Básicas de Saúde, entre Equipes de Saúde da Família e Equipes de Atenção Primária que recebem incentivo financeiro da SESAB mensalmente, através dos fundos municipais de saúde.

Um dos grandes desafios é consolidar a Estratégia de Saúde da Família nos Municípios, elevando a cobertura assistencial a 70% ou mais. Com isto, os usuários teriam uma possibilidade de acessar a rede a partir da APS.

Atualmente temos 26 Municípios com cobertura menor que 70% no Estado da Bahia (Tabela 1) e um estímulo importante para o avanço da estratégia é o investimento em construção, equipamento e informatização das Unidades Básicas.

Tabela 1- Municípios com menos de 70% de Cobertura na Estratégia de Saúde da Família, Bahia.

Ministério da Saúde - MS

Secretaria de Atenção Primária à Saúde - SAPS

Departamento de Saúde da Família - DESF

Cobertura da Estratégia de Saúde da Família

Unidade Geográfica: TODOS OS MUNICÍPIOS - BA

Período: Dezembro de 2020

| Município | População | Nº Equipes de Saúde da Família - ESF | Cobertura ESF |
|---|---|---|---|
| ALAGOINHAS | 151.596 | 30 | 68,27% |
| CAMAÇARI | 299.132 | 57 | 65,74% |
| CANDEIAS | 87.076 | 14 | 55,47% |
| CANDIBA | 14.319 | 2 | 48,19% |
| CARINHANHA | 29.018 | 5 | 59,45% |
| FEIRA DE SANTANA | 614.872 | 118 | 66,21% |
| FIRMINO ALVES | 5.617 | 1 | 61,42% |
| ILHÉUS | 162.327 | 22 | 46,76% |
| IPIRÁ | 59.595 | 11 | 63,68% |
| ITABUNA | 213.223 | 42 | 67,96% |
| ITAPETINGA | 76.147 | 14 | 63,43% |
| JEQUIÉ | 155.966 | 29 | 64,15% |
| LUÍS EDUARDO MAGALHÃES | 87.519 | 16 | 63,07% |
| MADRE DE DEUS | 21.093 | 4 | 65,42% |
| MAIQUINIQUE | 10.112 | 2 | 68,24% |
| PALMAS DE MONTE ALTO | 21.750 | 4 | 63,45% |
| PILÃO ARCADO | 35.048 | 5 | 49,22% |
| PINTADAS | 10.437 | 2 | 66,11% |
| RIACHÃO DO JACUÍPE | 33.436 | 5 | 51,59% |
| SALVADOR | 2.872.347 | 335 | 40,24% |
| SANTA INÊS | 10.631 | 2 | 64,90% |
| SANTA TERESINHA | 10.405 | 2 | 66,31% |

| | | |
|---|---|---|
| SEABRA | 44.091 | 754,77% |
| SIMÕES FILHO | 134.377 | 1846,21% |
| VALENÇA | 96.562 | 1864,31% |
| VITÓRIA DA CONQUISTA | 341.597 | 4848,48% |

Fonte: e-Gestor Atenção Básica, 2021 (Desenvolvido pela Coordenação Geral de Informação da Atenção Primária - CGIAP/DESF/SAPS).

Na perspectiva de estruturar uma Rede de Atenção à Saúde tendo a Atenção Básica como ordenadora da rede, coordenadora do cuidado de forma resolutiva e ascendente o Estado da Bahia adotou como estratégia a implantação das Policlínicas Regionais de Saúde, por meio de Consórcios Interfederativos, atuando de forma complementar à Atenção Básica.

Para tanto, seu ordenamento se dá por meio de protocolos de acesso para a Policlínica, em que trabalhadores da Atenção Básica participam de capacitação para que possam realizar o compartilhamento de casos com especialistas e solicitação de exames complementares com critérios técnicos.

O acesso a exames e consultas especializadas faz com que o usuário tenha sua condição de saúde melhor investigada pela Atenção Básica e sua conduta complementada por especialista da Policlínica. E, com isto, consiga-se avançar não só na estruturação de uma Rede Assistencial, mas na garantia de direito à integralidade assistencial.

O quantitativo de policlínicas atuais oferta serviços especializados ainda de forma insuficiente para todos os territórios do estado, sendo muitas vezes necessário o deslocamento de pacientes para outras regiões de saúde para realização de consultas de especialidades médicas e exames complementares. Dessa forma, justifica-se a necessidade de ampliação para as regiões centro- leste, sudoeste e sul, onde pretende-se com este projeto construir 3 policlínicas.

Existem ainda os Centros Estaduais de Referência, unidades da rede SUS que prestam atendimento a públicos ou situações específicas, através da assistência propriamente dita ou, em determinados casos, oriundos da atenção básica. Estas unidades também se constituem em campo de pesquisa em suas áreas, sendo eles: (i) Centro de Referência Estadual para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista - CRE-TEA, (ii) Centro de Referência Estadual para Assistência ao Diabetes e Endocrinologia - Cedeba, (iii) Centro de Informações Antiveneno - Ciave, (iv) Centro de Atenção à Saúde do Idoso - Creasi, (v) Centro de Prevenção e Reabilitação da Pessoa com Deficiência - Cepred, (vi) Centro de Referência em Doenças Endêmicas - PIEJ, (vii) Centro Estadual de Oncologia - Cican, (viii) Centro Estadual Especializado em Diagnóstico, Assistência e Pesquisa - Cedap (antigo CREAIDS) e (ix) Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador - Cesat.

Em relação à Atenção à Saúde Mental no estado, esta é orientada pelo Plano de Desinstitucionalização da Bahia, garantindo proteção aos direitos das pessoas com transtornos mentais, enfatizando a importância da garantia do cumprimento dos direitos deste público, e redirecionando o modelo assistencial em saúde mental. Assim, o estado propõe a substituição progressiva do modelo de atenção hospitalocêntrico, o qual exclui as pessoas com transtorno mental do convívio social, para um modelo de atenção de base comunitária de modo programado e responsável, envolvendo esforços dos três entes: Municípios, Estado e União, a partir da execução de ações em dois níveis: (i) a substituição progressiva da assistência nos hospitais psiquiátricos pela assistência nos pontos da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e (ii) a implementação efetiva da RAPS em todo o Estado.

Na saúde mental, esforços para ampliação e fortalecimento da RAPS com a construção de CAPS III, CAPS AD, CAPS I, Unidade de Acolhimento Infantil e Adulto em Saúde Mental (UA) e leitos de saúde mental no Hospital Metropolitano e a capacitação dos profissionais da rede são extremamente necessários, especialmente por conta do contexto da pandemia do COVID-19, que tem gerado aumento de demanda de atendimento em saúde mental. Enfatiza a necessidade em especialmente por serviços que ofereçam acolhimento noturno a pessoas com sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias psicoativas.

No Brasil, a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS, 2019), estimou que 17,3 milhões de pessoas de 2 anos ou mais de idade possuíam algum tipo de deficiência (visual, auditiva, motora ou mental). Esse número representava 8,4% da população nessa faixa etária no Brasil e na Bahia correspondia a 10,3% da população. O aumento da expectativa de vida, das condições crônicas de saúde, de condições congênitas relacionadas à STORCH+Z[1], as sequelas em decorrência da COVID-19, dentre outros fatores têm impactado na demanda por assistência em reabilitação. Além disso, o crescimento do número de judicializações geradas pelo vazio assistencial em reabilitação, têm exigido da gestão estadual da Bahia o delineamento de estratégias para ampliação de Centros Especializados em Reabilitação (CER) da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (RCPD).

O acesso do paciente à realização de exames ou avaliação médica especializada, requer, muitas vezes, que seja providenciada a transferência do paciente, sendo que a estratégia estadual do Saúde Sem Fronteiras conta com os serviços móveis de Mutirão de Cirurgias, rastreamento do câncer de mama (mamografia), oftalmologia, odontologia (Odontomóvel) e doação de sangue (Hemóvel).

Mais especificamente, O Hospital da Mulher possui uma unidade itinerante de atendimento que percorre todo o território baiano, atendendo mulheres para a realização do preventivo e de mamografia. A unidade é uma importante aliada no combate do câncer de mama e do colo do útero e é equipada com dois consultórios ginecológicos e um mamógrafo.

Outro importante serviço itinerante são os Hemóveis, que são unidades móveis que se deslocam para regiões com grande fluxo de pessoas, possibilitando a doação de sangue. Atualmente o estado possui 2 (dois) Hemóveis, sendo que cada um tem capacidade para coletar 120 bolsas de sangue em jornada de oito horas, além de fazer o cadastro para a doação de medula óssea. Uma amostra do DNA do doador vai para o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome) e, em caso de compatibilidade com algum paciente, o transplante é realizado. Em nível de captação, as unidades móveis superam 23 das 24 unidades de coleta no estado.

O estado conta também com o Laboratório Central de Saúde Pública Profº Gonçalo Moniz - LACEN/Ba, com seus 105 anos de história, reconhecido como a 3ª maior unidade de vigilância laboratorial do país, classificado na categoria máxima de qualidade pelo Ministério da Saúde. O LACEN/Ba compreende um conjunto de ações transversais aos demais sistemas de vigilância em saúde, propiciando conhecimento e investigação diagnóstica de agravos e verificação da qualidade de produtos de interesse para a saúde pública, mediante estudo, pesquisa e análises relacionados aos riscos epidemiológicos, sanitários, ambientais e da saúde do trabalhador, além de coordenar a Rede Estadual de Laboratórios de Saúde Pública -RELSP na Bahia.

Atualmente, a RELSP é composta de 25 (vinte e cinco) laboratórios, sendo: 01 (uma) Unidade Central, com gestão estadual; 12 (doze) laboratórios descentralizados de vigilância epidemiológica, sendo: 11 (onze) Laboratórios Municipais de Referência Regional (LMRR), com gestão compartilhada entre Estado e Município, e 01 (um) Laboratório Estadual de Referência Regional (LERR), com gestão estadual e 12 (doze) Laboratórios Regionais de Vigilância da Qualidade da Água (LVQA), gerenciados pelos Núcleos Regionais de Saúde, sendo 02 ( dois) em parceria com universidades, a saber: Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC (Ilhéus) e Universidade Federal do Oeste da Bahia - UFOB (Barreiras), 01 (um) no LMRR de Senhor do Bonfim e 01 (um) no LERR de Jequié.

A Rede Frio do estado da Bahia é um sistema amplo, que inclui estrutura técnico-administrativa vinculada aos Núcleos Regionais de Saúde e orientada pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), por meio de normatização, planejamento, avaliação e financiamento que visa à manutenção adequada da cadeia de frio, que é o processo logístico de conservação dos imunobiológicos, desde o laboratório produtor até o usuário, incluindo as etapas de recebimento, armazenamento, distribuição e transporte, de forma oportuna e eficiente, assegurando a preservação de suas características originais. Está organizada de forma descentralizada, contando atualmente com uma Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de imunobiológicos (CEADI), localizada no município de Simões Filho, com capacidade para armazenamento de aproximadamente de 542 m3, aproximadamente, 6.000.000 (seis milhões) de doses dos diferentes tipos de imunobiológicos que são disponibilizados pelo Ministério da Saúde para garantia da vacinação da população baiana, os quais são distribuídos, mensalmente, às 30 Centrais Regionais de Rede de Frio, localizadas no interior do estado, à capital e demais municípios da Região Metropolitana de Salvador, além dos Centros de Referência para imunobiológicos Especiais.

Através do monitoramento realizado sistematicamente junto às equipes das Centrais de Rede de Frio Regionais, verifica-se, para a maioria das Centrais Regionais, a necessidade de readequação em termos de redimensionamento de espaço físico em vista da ampliação da oferta de vacinas e ampliação dos públicos-alvo da vacinação de rotina e campanhas; tais como: correção de problemas de infiltração e mofo, com necessidade de pintura de paredes e tetos; manutenção corretiva da rede elétrica e hidráulica; adequação à temperatura ambiente recomendada, conforme preconizado pelo Programa Nacional de Imunizações, com climatização adequada, havendo a necessidade de troca de aparelhos de ar condicionado subdimensionados, antigos e/ou quebrados.

Diante da ampliação da oferta de vacinas e com a ampliação dos públicos-alvo da vacinação de rotina e campanha, faz-se necessária a requalificação da Rede de Frio, sendo imprescindível a aplicação de investimento para: Renovação do Parque Tecnológico, com substituição de Equipamentos das Centrais Regionais da Rede de Frio, incluindo câmaras frias para imunobiológicos, aparelhos de ar-condicionado, computadores e freezers.

Considerando que a Campanha Nacional de Vacinação contra COVID-19, processo excepcional e em construção, que triplica a capacidade de armazenamento inicialmente prevista, demandando infraestrutura mais robusta e estratégias mais dispendiosas a fim de aportar volume de insumos (imunobiológicos, diluentes, seringas e agulhas) em quantitativos vultuosos; A implementação das ações previstas no procedimento de recebimento, armazenamento, monitoramento, conservação e distribuição de imunobiológicos no Estado requer estrutura adequada que garantam a manutenção da propriedade imunizante desses produtos e as instalações adequadas ao armazenamento dos imunobiológicos que apresentam características peculiares.

A reforma, requalificação e aquisição de equipamentos dos Núcleos Regionais de Saúde e Rede de Frios; reforma e ampliação do Laboratório Central do Estado (LACEN); construção e aquisição de equipamentos de Laboratórios Regionais são importantes para o fortalecimento da rede de atenção à saúde, as ações de vigilância em saúde.

É importante destacar os desafios persistentes de operacionalizar o SUS em um estado, especialmente quando entende-se a necessidade de se efetivar a integralidade como o centro do processo, considerando as condições históricas e socioeconômicas de cada região e a garantia de acesso universal. A formatação de um padrão de integralidade para o atendimento na Bahia pressupõe: ambiência (modelo arquitetônico); tecnologia e informação; insumos (medicamentos e materiais médico-hospitalares) e exames; equipe; oferta de serviços e por fim, organização produtiva do trabalho.

Assim, em 2014 foi firmado o Contrato de Empréstimo entre o Governo do Estado da Bahia e o BID para o Programa de Fortalecimento do Sistema Único de Saúde na Região Metropolitana de Salvador - PROSUS. Nele realizou-se a estruturação da Atenção Integral à Saúde para superação dos vazios assistenciais em áreas prioritárias da Região Metropolitana de Salvador (RMS); fortaleceu-se a Regulação da Assistência à Saúde garantindo o acesso adequado dos usuários do SUS aos serviços disponibilizados na RMS; e promoveu o fortalecimento Institucional da SESAB consolidando o papel de coordenador geral do Sistema Estadual de Saúde. Essas ações se deram por meio da construção e implantação de 10 Unidades Básicas de Saúde (UBS); 13 Policlínicas de Saúde; 14 Academias da Saúde; 09 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS); 01 Unidade de Acolhimento Infanto Juvenil (UAIJ); 01 Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST); construção do Hospital Metropolitano, ampliação e reforma do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS) e do Hospital João Batista Caribé que passou a se chamar Maternidade Maria Conceição de Jesus; superando parcialmente os vazios assistenciais; além de promover o fortalecimento institucional através de capacitações para toda a rede SUS da RMS e gestores da SESAB. Foi também estabelecido pelo PROSUS I a implantação do Prontuário Eletrônico do Cidadão. O sistema que foi cedido pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, chamado AGHUse - Sistema de Acompanhamento e Gestão Hospitalar, implantado e utilizado em 8 serviços de referência do estado até o momento.

Dessa forma, visando o contínuo e necessário fortalecimento do SUS do estado da Bahia, e a ampliação das experiências exitosas do PROSUS I na RMS para as demais regiões do estado, serão propostas algumas soluções parte do desenho do Programa de Fortalecimento do SUS no Estado da Bahia - PROSUS II.

## 1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

Solução Proposta

Para fazer frente aos problemas apresentados propõe-se com o Programa de Fortalecimento do SUS no Estado da Bahia - PROSUS II a ampliação do acesso, o aumento da resolutividade e melhoria da qualidade dos serviços de saúde, bem como a qualificação da gestão através de um processo de informatização de toda a rede para as demais regiões da saúde do estado da Bahia.

Devido a escassez de recursos financeiros imprimidos pelo contexto atual da pandemia da COVID-19 e de sua consequente crise econômica, garantir saúde de qualidade, eficaz e com otimização dos custos se faz necessário.

A seguir, apresentaremos as soluções propostas ao enfrentamento do diagnóstico situacional apresentado por tópicos:

Atenção Básica

Apesar do avanço na cobertura da população do estado pela Estratégia de Saúde da Família - ESF, ainda há municípios cuja cobertura é inferior a 70%. Para além disto, temos ainda municípios com Equipes da ESF atuando em Unidades precárias e/ou alugadas, o que acarreta uma instabilidade da permanência da ESF e uma baixa qualidade assistencial. É imprescindível, portanto, a ampliação da sua cobertura para que a Atenção Básica priorize os Municípios com menos de 70% de cobertura, bem como, substituir as estruturas alugadas por Unidades próprias, para que a Atenção Básica possa se consolidar e assumir o papel de coordenação do cuidado e ordenação das Redes de Atenção à Saúde.

Além da ampliação do acesso à Atenção Básica, é necessário que esta seja resolutiva, estabeleça vínculo e se torne referência para as pessoas, coordene o cuidado e estabeleça o itinerário terapêutico do usuário na Rede de Atenção à Saúde. Por isso, o Projeto prevê também um investimento tecnológico que permita otimizar as ações da Atenção Básica gerando também, com isso, informações que subsidiem a tomada de decisão por parte da gestão e o acesso a tecnologias de telessaúde para a qualificação da assistência e para a regulação inteligente dos serviços especializados.

Telessaúde:

No que tange ao Telessaúde, cabe ressaltar que o Estado da Bahia possui o Núcleo Técnico Científico desde 2012. Criado a partir de um Projeto da Secretaria de Gestão do Trabalho Ensino e Serviço do Ministério da Saúde, em 2005, a Bahia só veio a aderir em 2011, desde então, já são mais de 14.235 profissionais cadastrados na Plataforma, em 3.637 Unidades Básicas de Saúde dos 417 Municípios da Bahia .

Dentre as ofertas consolidadas realizadas pelo Núcleo de Telessaúde da Bahia, podemos ressaltar:

Tele-educação - voltada para educação continuada, tem uma abrangência em todo o Estado. Tem um amplo acesso de trabalhadores de todas as áreas da saúde. Existe uma ampla agenda semanal e pode ser acessado via canal do You Tube, Plataforma da Rede Nacional de Pesquisa e Zoom.

Teleconsultoria - foi a precursora do Núcleo e que possibilita a discussão de casos, envio de materiais educativos de forma síncrona e assíncrona pela Plataforma do Telessaúde Bahia. Atualmente também é realizada Teleconsultoria Especializada, com parcerias com o Centro Estadual de Diabetes e Endocrinologia da Bahia ? CEDEBA, Centro de Câncer da Bahia e Faculdade de Medicina da Bahia/UFBA, bem como Telerregulação ao CEDEBA e Teleconsulta com a Faculdade de Medicina/UFBA.

Telediagnóstico - estruturado a partir da oferta nacional de telediagnóstico do MS, a SESAB oferece para os Municípios Baianos Telediagnóstico em ECG e Dermatologia. Estes exames são realizados na sua grande maioria em Unidades Básicas e auxiliam a um menor deslocamento dos Usuários e ampliação da resolutividade dos casos. Atualmente já são mais de 150 mil laudos realizados e presença em mais de 200 municípios.

Durante a Pandemia todas as ofertas do Núcleo de Telessaúde da Bahia foi potencializado, visto que é uma ferramenta de gestão que possibilita assistir de forma segura, com todos os aspectos éticos garantidos, resultando em uma redução de custo, ampliação da resolutividade assistencial, ampliação do acesso e potencialização das ações de Educação Permanente em meio às restrições impostas pela Pandemia.

Desta forma, a ampliação e qualificação das ofertas, via Núcleo de Telessaúde da Bahia possibilitará o ordenamento da rede a partir da Atenção Básica e a estruturação da Assistência Remota (Teleconsulta) em todos os níveis e com maior amplitude, bem como a organização do acesso no nível ambulatorial especializado.

Média e Alta Complexidade:

No tocante aos outros níveis do sistema de saúde, o Projeto visa a descentralização e regionalização das ações de média e alta complexidade, através do fortalecimento das Redes de Atenção à Saúde.

A ampliação de 3 Policlínicas, 20 CAPS, 15 CER e 40 novos leitos de UTI e Semi-Intensiva se justificam não só pela continuidade das ações do PROSUS I, alcançando assim todo o estado, mais também devido as necessidades decorrentes da pandemia da COVID-19, que demandam tanto acesso a serviços de alta complexidade, mas também apoio em saúde mental e reabilitação dos pacientes com sequelas da doença.

Também pretende-se investir nos serviços de apoio diagnóstico como as Carretas da Saúde da Mulher com Mamógrafos e consultórios ginecológicos, além dos 09 Hemóveis para captação de doadores de sangue que trará um impacto no aumento estimado de 3600 à 4000 mil bolsas coletadas por mês no abastecimento de hemocomponentes em todo o estado, considerando o aumento progressivo e significativo aumento no fornecimento de hemocomponentes.

Informatização do SUS Bahia:

A diretriz de modernização tecnológica também se estende à média e à alta complexidade através da ampliação da conectividade de todos os hospitais municipais, estaduais e filantrópicos e da continuidade da implantação do prontuário eletrônico nas unidades de saúde sob gestão estadual.

Importante destacar que a falta de um sistema de informação padrão que gerencie o atendimento realizado à população e os fluxos de processos assistenciais e administrativos, nas unidades de saúde sob gestão da SESAB, trazem prejuízos ao Estado, na demora ao acesso dos dados e informações importantes a alta gestão, além dos prejuízos operacionais no funcionamento dos próprios estabelecimentos de saúde.

Outro ponto importante a destacar é a certificação digital dos profissionais de saúde para que possam assinar digitalmente com validade jurídica documentos eletrônicos, como prescrições de medicamentos, atestados e laudos. Além de comprovar a identidade para acessar sistemas eletrônicos restritos, principalmente de órgãos públicos.

A qualidade da assistência dos serviços de saúde e da gestão da rede é outro componente essencial para a melhoria da saúde da população e para a resolução dos problemas identificados. Para isso, haverá o investimento na certificação e acreditação das Policlínicas e dos hospitais sob gestão estadual, bem como a implementação de sistemas de gestão e a capacitação dos gestores da saúde.

Dentre os potenciais impactos, está a melhoria do gerenciamento hospitalar e da qualidade da assistência prestada aos usuários. Além disso, a adoção voluntária de padrões de qualidade potencializa o reconhecimento público do hospital acreditado.

Tudo isso porque, os vários padrões disponíveis são baseados em áreas do gerenciamento hospitalar, que abrangem os princípios de garantia de qualidade, prática baseada em evidências, ética médica e segurança do paciente. Com efeito, é um meio estratégico para ajudar os serviços a aproveitarem ao máximo seus recursos e gerenciarem custos, e os pacientes e profissionais são os maiores beneficiados de uma acreditação hospitalar, pois ganham em segurança.

Núcleos de Saúde, Rede de Frios e Laboratório Central de Saúde Pública:

Com o advento da pandemia da COVID-19, a reestruturação dos Núcleos Regionais de Saúde para comportar as Redes Frios do estado e dos Lacens se fazem necessários para adequação da oferta de serviços prestados, na garantia da adequada imunização dos baianos, além de sua testagem e monitoramento de doenças.

Resultados Esperados

Os resultados esperados com a implementação deste programa são os seguintes:

Qualificar a gestão hospitalar através do processo de certificação e acreditação das Policlínicas e dos hospitais sob gestão estadual, além da implementação de sistemas de gestão e a capacitação dos gestores da saúde;

Ampliar a implantação de prontuário eletrônico para maior qualidade da informação, assistência e integração do sistema através dos Hospitais e Policlínicas do estado, além das novas Unidades Básicas de Saúde (UBS) construídas;

Ampliar o acesso aos serviços primários, através de novas UBS, secundários, através das policlínicas e terciários, como os Hospitais da rede de atenção nas regiões de saúde do estado;

Otimizar a alocação de recursos humanos dos serviços do estado, com a elaboração do estudo para dimensionamento da força de trabalho;

Ampliar a capacidade diagnóstica do estado (laboratorial e de imagem);

Ampliar o acesso a serviços através das ações do Núcleo de Telessaúde da Bahia; Capacitar gestores e profissionais de saúde para um cuidado integral e com maior eficiência do sistema.

Sustentabilidade

As ações propostas por este Programa para melhoria do sistema de saúde do estado da Bahia foram pensadas considerando os custos adicionais ao sistema, mas que ao fim racionalizam e reorganizam a assistência trazendo maior custo-efetividade e benefícios a população.

O Projeto de Fortalecimento do SUS no Estado da Bahia - PROSUS I foi responsável por garantir a expansão da rede de atenção à saúde para toda a região metropolitana. A necessidade de se garantir acesso aos serviços de saúde e aos cuidados integrados para todas as regiões do estado da Bahia justifica a necessidade do PROSUS II.

Ele será responsável pela ampliação da infraestrutura da rede de atenção à saúde por meio de novas Unidades Básicas de Saúde, Centros de Atenção Psicossocial, Policlínicas, Centros Especializados de Reabilitação e Leitos de Unidade de Terapia Intensiva, além das reformas e ampliações propostas na Rede Frio e Lacens.

Os investimentos em tecnologia da informação e comunicação (TIC) se fazem necessários para modernização dos serviços, e dos processos de trabalho, para um maior apoio a tomada de decisão e também maior custo-efetividade das ações, que ao fim, racionalizam e reorganizam a assistência trazendo maior custo-efetividade.

Os investimentos aqui propostos serão duradouros, pois muitos deles fazem parte da gestão por meio dos Consórcios Interfederativos de Saúde, que consistem na junção de municípios por Regiões de Saúde do estado, para unir esforços e dividir os custos com a assistência à Saúde de seus habitantes. Esse modelo de gestão visa ampliar a assistência de saúde da média e alta complexidade nos municípios baianos, possibilitando que o cidadão tenha um atendimento de qualidade de média complexidade, com a oferta de consultas de diversas especialidades médicas e a realização de exames de imagem e outros em policlínicas. Além disso, prevê a adequação e melhoria de hospitais e outras unidades de saúde voltadas para fazer o atendimento também de alta complexidade. Tudo isso com o objetivo de ser perto de casa, para que o paciente não precise se deslocar longas distâncias para conseguir atendimento.

Os recursos para contratações dos serviços que serão implantados, como Unidades Básicas de Saúde são viabilizados pela Política Nacional de Atenção Básica e o Incentivo Financeiro Estadual para a Estratégia de Estruturação da Rede de Atenção à Saúde, bem como os Serviços de Reabilitação, Atenção Psicossocial recebem financiamento das Políticas Respectivas constantes na Portaria de Consolidação nº 6 de 28 de setembro de 2017.

Os investimentos às ações previstas ao apoio aos serviços de diagnóstico como a reforma e ampliação do Laboratório Central do Estado ( LACEN), certificação NB3 e construção de Laboratórios Regionais, serão sustentados posteriormente, após a implementação, por meio de recursos próprios do estado para custeio da Vigilância em Saúde.

## 1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

Orientações Estratégicas

As ações descritas nesse projeto estão em linha com o Plano Estadual de Saúde 2020-2023 (SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, 2019), em especial com os seguintes compromissos:

Compromisso 2 - Fortalecer a Atenção Básica de forma integrada e resolutiva. O Projeto contribuirá com a consolidação da Atenção Básica, através da ampliação do acesso e de sua resolutividade, da qualificação do cuidado e da gestão, bem como através do fortalecimento de seu papel de coordenação do cuidado centrado nas necessidades das pessoas.

Compromisso 3 - Potencializar a Rede de Atenção à Saúde - RAS de forma regionalizada, ampliando a equidade de acesso, garantindo a integralidade e a segurança do paciente. O Projeto contribuirá com a melhoria da cobertura assistencial, a qualificação das ações e dos serviços de saúde, a ampliação do acesso e da regulação da oferta da atenção especializada.

Compromissos 4 - Promover a valorização do trabalho e do trabalhador no SUS/BA. O projeto visa contribuir para a capacitação de profissionais de saúde e gestores de forma a capacitar e valorizar o trabalho, promovendo estratégias para reorientar o sistema e os serviços, segundo a lógica da promoção da saúde e contribuir com a melhoria da gestão e do cuidado.

Compromisso 5 - Potencializar a Atenção Hematológica e Hemoterápica à população da Bahia. As ações do projeto visam potencializar a atenção hematológica e hemoterápica à população baiana, para a produção e fornecimento de hemocomponentes com qualidade e em quantidade suficiente ao atendimento da demanda da rede de saúde do Estado da Bahia.

Compromisso 6 - Fortalecer a capacidade de gestão estadual do SUS, qualificando as ações de sistematização, monitoramento e fiscalização, ampliando os canais de diálogo com a sociedade e o exercício do controle social. O Projeto contribuirá com o aperfeiçoamento da gestão do sistema, o desenvolvimento de processos de planejamento com base nas necessidades de saúde da população, a organização de serviços, o planejamento regional integrado e a transparência da gestão do sistema.

Contrapartida

A contrapartida do Estado da Bahia para o Programa de Fortalecimento do SUS no Estado da Bahia - Prosus II está de acordo com o disposto na Resolução COFIEX nº 2 de 05/09/2017, sendo no valor de US$ 37.500.000,00, correspondendo a pelo menos 20% do valor total do programa. Este valor da contrapartida deverá ser aplicado na gestão das unidades construídas com recursos PROSUS, principalmente, no Hospital Metropolitano e Policlínicas Regionais de Saúde.

Taxa de Câmbio

A taxa de câmbio adotada como valor de referência é de U$ 1,00 dólar por R$ 5,04 reais, em 07 de junho de 2021.

## 2. Projeto

**2.1. Título**
Programa de Fortalecimento do SUS no Estado da Bahia - PROSUS II

**2.2. Título Abreviado**
PROSUS II

**2.3. Mutuário**
Estado da Bahia

**2.4. Tipo Operacao**
Operação de crédito externo

**2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS**
Objetivo Geral

O Programa de Fortalecimento do SUS no Estado da Bahia visa ampliar o acesso e a qualidade dos serviços de saúde na rede de atenção do estado, através do fortalecimento da atenção básica e da descentralização e regionalização das ações de média e alta complexidade.

Objetivos Específicos

Fortalecer a gestão do Sistema Único de Saúde da Bahia e a apoiar as tomadas de decisões através da inovação e da incorporação de soluções de tecnologia da informação na gestão hospitalar, logística, gestão de recursos humanos e modernização do parque tecnológico da SESAB;

Apoiar o modelo de gestão das Redes de Atenção à Saúde através da capacitação de gestores e profissionais do SUS/BA;

Expandir e melhorar a oferta de serviços de atenção primária, atenção secundária e terciária nas regiões de saúde do estado;

Melhorar a oferta de serviços de apoio diagnóstico laboratorial e imunológico através do LACEN e Rede Frios;

Ampliar o acesso à rede de serviços do SUS/BA através do Núcleo de Telessaúde da Bahia;

**2.6. Projeto/Indicadores**

| Descrição | Fórmula de Cálculo | Unidade de Medida | Linha de Base | Meta |
|---|---|---|---|---|
| População Coberta pela Atenção Básica no Estado da Bahia | % da População Estimada Coberta pela Atenção Básica | % - Percentual | 76,00 | 93,00 |
| Municípios com Prontuário Eletrônico do Cidadão | Nº de municípios com Prontuário Eletrônico do Cidadão x 100 / Total de Municípios no Estado | % - Percentual | 20,00 | 50,00 |
| Unidades da SESAB com Prontuário Eletrônico Implantado | Nº de Unidades da SESAB com Prontuário Eletrônico Implantado | % percentual | 20,00 | 100,00 |
| Ampliação dos Serviços de Telessaúde/ Telemedicina do Estado da Bahia | Nº de Serviços de Telessaúde/ Telemedicina implantados | Número Absoluto | 3,00 | 5,00 |
| Número de Políclinas Regionais de Saúde do Estado | Nº de Policlínicas Regionais de Saúde do Estado | Número Absoluto | 21,00 | 24,00 |
| Cobertura da Estratégia de Saúde da Família, Indicador de Impacto | Numero de Equipes da Estratégia de Saúde da Família X 3450 / População Estimada X 100 | % percentual | 76,00 | 90,00 |
| Internação por condições sensíveis à atenção primária, Indicador de Impacto | Número de internações hospitalares de residentes financiados pelo SUS, por causa sensíveis à atenção primaria X 100/ número total de internações hospitalares de residentes financiadas pelo SUS | % percentual | 10,30 | 8,80 |
| Taxa de Mortalidade Prematura por Doenças Crônicas Não Transmissíveis Implantado, Indicador de Impacto | Numero de óbitos(de 30 a 69anos) registrados nos códigos CID-10 I00-I99, C00-C97, J30-J98 , E10-E14 X 100.000/ População residente ( de 30 a 69 anos) | Proporção | 238,80 | 226,90 |
| Taxa de Mortalidade Infantil, Indicador de Impacto | Número de óbitos de residentes de menos 1 ano de idade X 1000 / Número de nascidos vivos de mães residentes. | Proporção | 18,00 | 14,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Razão de Mortalidade Materna, Indicador de Impacto | Número de mortes de mulheres entre 10 e 49 anos classificadas no Capítulo XV da CID 10, com exceção dos códigos O96 e O97 (Morte Materna Tardia e Morte por Seqüela de Causa Obstétrica Direta), em um determinado ano e local de residência x 100 mil. Inclui os óbitos codificados na CID 10 como: O00.0 a O08.9, O11 a O23.9, O24.4, O26.0 a O92.7 / Número de nascidos vivos, de mães residentes no mesmo local, no ano considerado. | Proporção | 72,56 | 70,00 |
| Taxa de incidência de sífilis congênita em menores de 1 ano, Indicador de Impacto | Número de casos novos de sífilis congênita em menores de 1 ano de idade X 1.000/ Número total de nascidos vivos, de mães residentes.CID-10: A50. | Proporção | 6,60 | 5,94 |
| Imunização de menores de 1 ano por pentavalente, Indicador de Impacto | Número de crianças menores de 1 ano que receberam a terceira dose de pentavalente X 100/ População total de crianças menores de 1 ano residente. | % Percentual | 44,10 | 95,00 |

**2.7. Projeto/Componentes**

| Componentes | Valor(US$) |
|---|---|
| **C - AMPLIAÇÃO DO ACESSO E DA RESOLUTIVIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA** | **48.500.000,00** |
| S - AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE NO ESTADO | 44.700.000,00 |
| P - Construção de Unidades Básicas de Saúde (UBS) | 40.000.000,00 |
| P - Aquisição de Equipamentos de TIC, mobiliario e demais bens necessários para as UBS | 4.500.000,00 |
| P - Equipamentos para implantação de 200 salas de pé diabético | 200.000,00 |
| S - INVESTIMENTO TECNOLÓGICO NA ATENÇÃO BÁSICA | 3.800.000,00 |
| P - Apoio a implantação do Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) nas unidades | 700.000,00 |
| P - Finalização da implementação do Centralizador e transferência de tecnologia para utilização futura da REDS - Rede estadual de dados em saúde (barramento de serviços do estado) | 200.000,00 |
| P - Evolução e sustentação da REDS | 1.500.000,00 |
| P - Aquisição de equipamentos para telediagnóstico na Atenção Básica | 1.000.000,00 |
| P - Capacitações de curta duração para agregar e qualificar práticas e serviços | 400.000,00 |
| **C - DESCENTRALIZAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE** | **114.700.000,00** |
| S - FORTALECIMENTO DE SERVIÇOS DA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE | 107.100.000,00 |
| P - Construção de 03 Policlínicas regionais de saúde | 7.400.000,00 |
| P - Funcionamento de 18 policlínicas no Estado da Bahia | 17.500.000,00 |
| P - Funcionamento do Hospital Metropolitano | 20.000.000,00 |
| P - Aquisição de Equipamentos Policlínicas | 7.500.000,00 |
| P - Reforma, Ampliação do Hospital Geral Ernesto Simões | 5.500.000,00 |
| P - Reforma e requalificação de estruturas descentralizadas de gestão do estado | 3.500.000,00 |
| P - Aquisição de equipamentos para Núcleos Regionais e Rede de Frios | 1.000.000,00 |
| P - Ampliação do número de leitos em Unidades de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva | 3.000.000,00 |
| P - Construção de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) | 7.800.000,00 |
| P - Aquisição de Equipamentos dos CAPS | 800.000,00 |
| P - Construção de Unidades de Acolhimento (UA) | 1.600.000,00 |
| P - Aquisição de Equipamentos das Unidades de Acolhimento (UA) | 200.000,00 |
| P - Construção de Centros Especializados de Reabilitação (CER) | 18.000.000,00 |
| P - Aquisição de Equipamentos CER | 11.500.000,00 |
| P - Aquisição de Hemóveis para Macrorregiões | 1.800.000,00 |
| S - APOIO AOS SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS DA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE | 7.600.000,00 |
| P - Aquisição de Carretas de Exames de Mamografia | 600.000,00 |
| P - Reforma e ampliação do Laboratório Central do Estado (LACEN) | 3.500.000,00 |
| P - Construção de Laboratórios Regionais (LACEN) | 2.000.000,00 |
| P - Aquisição de equipamentos para Laboratórios do Estado | 1.500.000,00 |
| **C - FORTALECIMENTO DA GESTÃO, QUALIDADE E EFICIÊNCIA DA REDE SUS BAHIA** | **14.900.000,00** |
| S - AMPLIAÇÃO DA EFICIÊNCIA E QUALIDADE DA REDE HOSPITALAR | 3.900.000,00 |
| P - Certificação e acreditação dos hospitais e policlínicas sob gestão ou consorciadas com o estado | 1.000.000,00 |
| P - Certificado Digital para as equipes da rede hospitalar | 900.000,00 |
| P - Gestão e controle de acesso na rede hospitalar (Interoperabilidade com prontuário eletrônico) | 2.000.000,00 |
| S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E DA GESTÃO DA REDE SUS BAHIA | 11.000.000,00 |
| P - Ampliação para implantação do Prontuário Eletrônico na Rede SUS (SESAB | 1.500.000,00 |
| P - Dimensionamento da Força de Trabalho | 500.000,00 |
| P - Ampliação e Qualificação de Telessaúde e Telemedicina, incluindo Teleconsultas p/ Urgências, Telelaudos para Telediagnóstico, Telerregulação ambulatorial especializada, Teleconsultas para APS e Teleconsultoria. | 9.000.000,00 |
| **C - GESTÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO - UNIDADE GESTORA DO PROGRAMA (UGP)** | **9.400.000,00** |
| S - GESTÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO | 9.400.000,00 |
| P - Implantação de uma Unidade Gestora do Programa e de Supervisão de obras | 7.400.000,00 |
| P - Contratação de empresa para desenvolver os Projetos Executivos | 1.000.000,00 |
| P - Estudos de avaliação de médio prazo e de impacto | 1.000.000,00 |
| **Total dos Componentes** | **187.500.000,00** |

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

**Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:**

**C - AMPLIAÇÃO DO ACESSO E DA RESOLUTIVIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA**

Visa a ampliação do acesso aos serviços de saúde e a resolutividade das ações da atenção básica no estado da Bahia.

**S - AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE NO ESTADO**

Ampliação da infraestrutura da atenção básica no estado da Bahia.

**P - Construção de Unidades Básicas de Saúde (UBS)**

Construção de unidades básicas de saúde tipo I,II,III e IV

**P - Aquisição de Equipamentos de TIC, mobiliario e demais bens necessários para as UBS**

Aquisição de Equipamentos de TIC (estações de trabalho: desktops, monitores, teclado, mouse ou notebooks e impressoras), além de mesas, cadeiras, macas, armários, escadas, negatoscópio e demais equipamentos e mobiliários necessários para o funcionamento de uma UBS.

**P - Equipamentos para implantação de 200 salas de pé diabético**
Aquisição de Equipamentos para implantação de salas de pé diabético.

**S - INVESTIMENTO TECNOLÓGICO NA ATENÇÃO BÁSICA**
Ações de investimento tecnológico na atenção básica, como Prontuário Eletrônico e estruturação do parque tecnológico.

**P - Apoio a implantação do Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) nas unidades**
Implantação de sistema que permite o acompanhamento do histórico médico do paciente em qualquer serviço de saúde local, melhorando a coordenação do cuidado ao paciente.

**P - Finalização da implementação do Centralizador e transferência de tecnologia para utilização futura da REDS - Rede estadual de dados em saúde (barramento de serviços do estado)**
A instalação centralizador tem a função de reunir os dados de transmissão dos Prontuário Eletrônico do Cidadão - PEC do município, Estado ou região, fortalecendo uma organização hierárquica no fluxo da informação na esfera municipal/estadual e da produção de relatórios. A finalização da implementação do Centralizador possibilitará o acesso a dados produzidos nas Unidades Básicas de Saúde e integrá-las à REDS.

**P - Evolução e sustentação da REDS**
A Rede Estadual de Dados em Saúde (REDS) é a plataforma estadual de interoperabilidade de dados em saúde. É um projeto estruturante para a transformação digital da saúde no estado da Bahia e tem o objetivo de promover a troca de informações entre os pontos da Rede de Atenção à Saúde, permitindo a transição e continuidade do cuidado nos setores público.

**P - Aquisição de equipamentos para telediagnóstico na Atenção Básica**
Aquisição de equipamentos para telediagnóstico na Atenção Básica como ECG, Ofltalmoscópio e Dermatoscópio.

**P - Capacitações de curta duração para agregar e qualificar práticas e serviços**
Realização de capacitações para profissionais de saúde e gestores de curta duração para agregar e qualificar práticas e serviços

**C - DESCENTRALIZAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**
Visa o fortalecimento da infraestrutura da rede de atenção a saúde de média e alta complexidade, através de sua descentralização.

**S - FORTALECIMENTO DE SERVIÇOS DA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE**
Visa fortalecer os serviços da rede de atenção a saúde de média e alta complexidade, através de reformas e aquisições de equipamentos.

**P - Construção de 03 Policlínicas regionais de saúde**
Construção de 03 Policlínicas regionais de saúde

**P - Funcionamento de 18 policlínicas no Estado da Bahia**
Participação do estado no custeio das 18 Policlínicas nas Regiões de Saúde.

**P - Funcionamento do Hospital Metropolitano**
Custeio do Hospital Metropolitano

**P - Aquisição de Equipamentos Policlínicas**
Aquisição de equipamentos, mobiliário e demais bens de uso permanente necessários para o funcionamento das Policlínicas.

**P - Reforma, Ampliação do Hospital Geral Ernesto Simões**
Reforma/ Ampliação/ do Hospital Geral Ernesto Simões

**P - Reforma e requalificação de estruturas descentralizadas de gestão do estado**
Reforma e requalificação dos Núcleos Regionais e Rede de Frios.

**P - Aquisição de equipamentos para Núcleos Regionais e Rede de Frios**
Aquisição de equipamentos para Núcleos Regionais e Rede de Frios

**P - Ampliação do número de leitos em Unidades de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva**
Ampliação dos leitos de Unidades de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva.

**P - Construção de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS)**
Construção de Novos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS).

**P - Aquisição de Equipamentos dos CAPS**
Aquisição de equipamentos mobiliário e demais bens de uso permanente necessários para os CAPS.

**P - Construção de Unidades de Acolhimento (UA)**
Construção de Novas Unidades de Acolhimento (UA)

**P - Aquisição de  Equipamentos das Unidades de Acolhimento (UA)**
Aquisição de  equipamentos mobiliário e demais bens de uso permanente necessários para as Unidades de Acolhimento (UA)

**P - Construção de Centros Especializados de Reabilitação (CER)**
Construção de Centros Especializados de Reabilitação (CER).

**P - Aquisição de Equipamentos CER**
Aquisição de equipamentos mobiliário e demais bens de uso permanente necessários para os CER.

**P - Aquisição de Hemóveis para Macrorregiões**
Aquisição de Novos Hemóveis

**S - APOIO AOS SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS DA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE**
Visa equipar e reformar unidades de atendimento de apoio a diagnóstico, como mamógrafos e os Laboratórios Regionais (Lacen).

**P - Aquisição de Carretas de Exames de Mamografia**
Aquisição de Carretas de Exames de Mamografia

**P - Reforma e ampliação do Laboratório  Central do Estado (LACEN)**
Reforma e ampliação do Laboratório Central do Estado (  LACEN)

**P - Construção de Laboratórios Regionais (LACEN)**
Construção de Laboratórios Regionais (LACEN)

**P - Aquisição de equipamentos para Laboratórios do Estado**
Aquisição de equipamentos para os laboratórios central e regionais.

**C - FORTALECIMENTO DA GESTÃO, QUALIDADE E EFICIÊNCIA DA REDE SUS BAHIA**
Visa fortalecer a gestão, através do uso de tecnologia da informação e certificações, possibilitando aumento na sua qualidade e eficiência.

**S - AMPLIAÇÃO DA EFICIÊNCIA E QUALIDADE DA REDE HOSPITALAR**
Através de certificações, certificado digital e controle de acesso de funcionários o estado fará melhor gestão dos recursos humanos dos serviços de saúde.

**P - Certificação e acreditação dos hospitais e policlínicas sob gestão ou consorciadas com o estado**
Certificação e acreditação dos hospitais e policlínicas sob gestão estadual implantados nos últimos 5 anos.

**P - Certificado Digital para as equipes da rede hospitalar**
Certificado Digital para as equipes da rede hospitalar

**P - Gestão e controle de acesso na rede hospitalar (Interoperabilidade com prontuário eletrônico)**
Serviços e equipamentos para gerenciar o acesso e frequência dos profissionais de saúde e dos cidadãos, bem como gerenciar a escala dos profissionais.

**S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E DA GESTÃO DA REDE SUS BAHIA**
Visa o fortalecimento institucional e melhor gestão da rede SUS Bahia através de capacitações, ampliações e consultorias.

**P - Ampliação para implantação do Prontuário Eletrônico na Rede SUS (SESAB**
Implantação do Prontuário Eletrônico na Rede SUS (SESAB)

**P - Dimensionamento da Força de Trabalho**
Estudo de dimensionamento da força de trabalho das Unidades da Rede SUS (SESAB)

**P - Ampliação e Qualificação de Telessaúde e Telemedicina, incluindo Teleconsultas p/ Urgências, Telelaudos para Telediagnóstico, Telerregulação ambulatorial especializada, Teleconsultas para APS e Teleconsultoria.**
Ampliação e Qualificação de serviços de Telessaúde e Telemedicina, incluindo Teleconsultas p/ Urgências, Telelaudos para Telediagnóstico, Telerregulação ambulatorial especializada, Teleconsultas para APS e Teleconsultoria

**C - GESTÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO - UNIDADE GESTORA DO PROGRAMA (UGP)**
Responsável por garantir apoio ao projeto através da contratação de uma gerenciadora, além de avaliação de impacto e demais consultorias necessárias.

**S - GESTÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO**
Responsável por garantir apoio ao projeto através da contratação de uma gerenciadora, além de avaliação de impacto e demais consultorias necessárias para o bom andamento da execução do projeto.

**P - Implantação de uma Unidade Gestora do Programa e de Supervisão de obras**
Contratação de consultores para apoio a Unidade Gestora do Programa, para o apoio a equipe da SES/SE no planejamento, execução e avaliação das ações do Programa.

**P - Contratação de empresa para desenvolver os Projetos Executivos**
Contratação de empresa para desenvolver os Projetos Executivos

**P - Estudos de avaliação de médio prazo e de impacto**
Contratação de estudos de avaliação de médio prazo e do impacto gerado pelo programa

| Categoria de Gasto | Unidade de medida | Meta | Valor | % Financeiro |
|---|---|---|---|---|
| **Obras** | - | - | **92.300.000,00** | **49,23** |
| P- Construção de Unidades Básicas de Saúde ( UBS) | unidade | 80,00 | 40.000.000,00 | 21,33 |
| P- Construção de 03 Policlínicas regionais de saúde | policlinica construida | 3,00 | 7.400.000,00 | 3,95 |
| P- Reforma, Ampliação do Hospital Geral Ernesto Simões | Unidade hospitalar | 1,00 | 5.500.000,00 | 2,93 |
| P- Reforma e requalificação de estruturas descentralizadas de gestão do estado | nucleos regionais | 9,00 | 3.500.000,00 | 1,87 |
| P- Ampliação do número de leitos em Unidades de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva | leitos ampliados | 30,00 | 3.000.000,00 | 1,60 |
| P- Construção de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) | unidade de CAPS | 20,00 | 7.800.000,00 | 4,16 |
| P- Construção de Unidades de Acolhimento (UA) | unidades de acolhimento | 4,00 | 1.600.000,00 | 0,85 |
| P- Construção de Centros Especializados de Reabilitação (CER) | CER construido | 15,00 | 18.000.000,00 | 9,60 |
| P- Reforma e ampliação do Laboratório Central do Estado (LACEN) | LACEN reformado e ampliad | 1,00 | 3.500.000,00 | 1,87 |
| P- Construção de Laboratórios Regionais (LACEN ) | unidades novas | 5,00 | 2.000.000,00 | 1,07 |
| **Bens** | - | - | **30.600.000,00** | **16,32** |
| P- Aquisição de Equipamentos de TIC, mobiliario e demais bens necessários para as UBS | UBS equipadas | 80,00 | 4.500.000,00 | 2,40 |
| P- Equipamentos para implantação de 200 salas de pé diabético | unidade | 200,00 | 200.000,00 | 0,11 |
| P- Aquisição de equipamentos para telediagnóstico na Atenção Básica | Grupo de equipamentos | 125,00 | 1.000.000,00 | 0,53 |
| P- Aquisição de Equipamentos Policlínicas | policlinicas equipadas | 3,00 | 7.500.000,00 | 4,00 |
| P- Aquisição de equipamentos para Núcleos Regionais e Rede de Frios | nucleos regionais equip | 9,00 | 1.000.000,00 | 0,53 |
| P- Aquisição de Equipamentos dos CAPS | CAPS equipados | 20,00 | 800.000,00 | 0,43 |
| P- Aquisição de Equipamentos das Unidades de Acolhimento (UA) | unidade de acolhimento eq | 4,00 | 200.000,00 | 0,11 |
| P- Aquisição de Equipamentos CER | CER equipado | 15,00 | 11.500.000,00 | 6,13 |
| P- Aquisição de Hemóveis para Macrorregiões | Hemóveis adquiridos | 9,00 | 1.800.000,00 | 0,96 |
| P- Aquisição de Carretas de Exames de Mamografia | Carretas adquiridas | 2,00 | 600.000,00 | 0,32 |
| P- Aquisição de equipamentos para Laboratórios do Estado | laboratorios equipados | 6,00 | 1.500.000,00 | 0,80 |
| **Consultoria** | - | - | **12.800.000,00** | **6,83** |
| P- Capacitações de curta duração para agregar e qualificar práticas e serviços | Profissionais capacitados | 1.000,00 | 400.000,00 | 0,21 |
| P- Certificação e acreditação dos hospitais e policlínicas sob gestão ou consorciadas com o estado | Unid. certificadas, acred | 23,00 | 1.000.000,00 | 0,53 |
| P- Ampliação para implantação do Prontuário Eletrônico na Rede SUS (SESAB | serviços c AGHUSE implant | 32,00 | 1.500.000,00 | 0,80 |
| P- Dimensionamento da Força de Trabalho | Relatorio rede SUS-SESAB | 1,00 | 500.000,00 | 0,27 |
| P- Implantação de uma Unidade Gestora do Programa e de Supervisão de obras | equipe apoio a UGP | 1,00 | 7.400.000,00 | 3,95 |
| P- Contratação de empresa para desenvolver os Projetos Executivos | Equipe de apoio a UGP | 1,00 | 1.000.000,00 | 0,53 |
| P- Estudos de avaliação de médio prazo e de impacto | estudo | 1,00 | 1.000.000,00 | 0,53 |
| **Outros** | - | - | **51.800.000,00** | **27,63** |
| P- Apoio a implantação do Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) nas unidades | UBS com PEC implantado | 80,00 | 700.000,00 | 0,37 |
| P- Finalização da implementação do Centralizador e transferência de tecnologia para utilização futura da REDS - Rede estadual de dados em saúde (barramento de serviços do estado) | Centralizador implantado | 1,00 | 200.000,00 | 0,11 |
| P- Evolução e sustentação da REDS | REDS aprimorada | 1,00 | 1.500.000,00 | 0,80 |
| P- Funcionamento de 18 policlínicas no Estado da Bahia | valor mensal | 18,00 | 17.500.000,00 | 9,33 |
| P- Funcionamento do Hospital Metropolitano | valor mensal | 1,00 | 20.000.000,00 | 10,67 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| P- Certificado Digital para as equipes da rede hospitalar | quantidade certificados | 34.000,00 | 900.000,00 | 0,48 |
| P- Gestão e controle de acesso na rede hospitalar (Interoperabilidade com prontuário eletrônico) | unid com controle implant | 32,00 | 2.000.000,00 | 1,07 |
| P- Ampliação e Qualificação de Telessaúde e Telemedicina, incluindo Teleconsultas p/ Urgências, Telelaudos para Telediagnóstico, Telerregulação ambulatorial especializada, Teleconsultas para APS e Teleconsultoria. | serviços implantados | 5,00 | 9.000.000,00 | 4,80 |
| **Total Geral** | **-** | **-** | **187.500.000,00** | **100,00** |

**2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS**

Etapas Realizadas

Dentre as etapas já realizadas e que possibilitam a qualificação e consolidação de um projeto que atua sobre os principais problemas de comunicação, inovação tecnológica e acesso a serviços e exames especializados na saúde, ressaltamos que:

O Núcleo Técnico Científico Telessaúde Bahia foi implantado no ano de 2012, a partir do Convênio firmado entre o Governo do Estado com a Secretaria de Gestão do Trabalho, Ensino e da Saúde - SGTES/MS, com o objetivo de implantar 100 (cem) pontos de Telessaúde nas Unidades Básica de Saúde, com a proposta de potencializar a qualificação da Atenção Básica/Estratégia Saúde da Família, visando a melhoria da qualidade e resolubilidade dos serviços e cuidados em saúde. Atualmente o projeto faz parte do Programa Telessaúde Brasil Redes*, visa o melhor desenvolvimento e capacitação dos profissionais da AB, através das ofertas de Teleconsultoria, Teleducação, Telediagnóstico e Segunda Opinião Formativa (SOF), dirigidos a todas as categorias de profissionais de saúde na Atenção Básica (AB), que compõe as equipes de Saúde da Família, Núcleos de Apoio à Saúde da Família, Consultório na Rua e Programa de Saúde na Escola (PSE) e possui 15.028 (quinze mil e vinte oito) profissionais cadastrados em 3.751 (três mil, setecentos e cinquenta e uma) Unidades Básicas e já realizou mais de 19 mil Teleconsultorias e atingiu 174.323 (cento e setenta e quatro mil , trezentos e vinte três) participantes ao vivo em Webpalestras.

Já as Policlínicas Regionais de Saúde estão mudando a realidade da assistência de média e alta complexidade na Bahia. Construídas em locais estratégicos no interior do estado, possibilitam descentralizar a assistência, regionalizando o atendimento ao cidadão, que passou a ter acesso aos serviços perto de casa, sem precisar se deslocar longas distâncias ou aguardar tempo excessivo para o atendimento.Para viabilizar as Policlínicas e o atendimento regional, foram criados os Consórcios Interfederativos de Saúde, que administram as unidades, com a participação do Estado no custeio do serviço e da sede do Consórcio.

A demanda pela modernização tecnológica nas unidades de saúde cresceu exponencialmente na Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB, mediante a necessidade de implantação de um sistema de gestão hospitalar, que contemplasse o prontuário eletrônico do cidadão, visando a qualificação do atendimento e a unicidade do dado. Foi estabelecido que o programa PROSUS I contemplaria a demanda de implantação do prontuário eletrônico do cidadão. O sistema que foi cedido pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, chamado AGHUse - Sistema de Acompanhamento e Gestão Hospitalar, para ser implantado e utilizado foram necessários diversos investimentos na área de infraestrutura das unidades de saúde apoiadas pelo citado programa. O AGHUse é um sistema completo, moderno e desenvolvido dentro de padrões internacionais de qualidade e segurança de software, de modo que possui o prontuário eletrônico e todos os módulos para gestão clínica e administrativa para as unidades de saúde. O modelo de gestão abrange os processos, as ações administrativas, os controles operacionais, os fluxos de trabalho e as análises de informações e indicadores, buscando melhorar a eficiência operacional, econômica e administrativa das unidades de saúde. Foi iniciado o processo de implantação do Prontuário nas unidades de saúde estabelecidas pelo PROSUS 1, no qual, de 2020 ao final 2021 deteremos a implantação de 8 unidades de saúde, de modo que otimizaremos toda a parte assistencial e operacional dessas unidades, gerando economicidade e mais qualidade no atendimento ao cidadão. Para as demais 24 unidades, continuaremos no processo de implantação do prontuário eletrônico - AGHUse, que está seguindo em paralelo nas 8 unidades de saúde, e já se encontra em processo de finalização. Para tanto, precisaremos do PROSUS 2 para apoiar a continuidade e finalização das 24 unidades restantes, no intuito de modernizar e abarcar a implantação para todas as unidades de Saúde do Estado da Bahia.

Em dezembro de 2014 foi firmado o Contrato de Empréstimo entre o Governo do Estado da Bahia e o BID para o Programa de Fortalecimento do Sistema Único de Saúde na Região Metropolitana de Salvador - PROSUS. Para atingir tal objetivo realizou-se a estruturação da Atenção Integral à Saúde para superação dos vazios assistenciais em áreas prioritárias; fortaleceu-se a Regulação da Assistência à Saúde garantindo o acesso adequado dos usuários do SUS aos serviços disponibilizados na RMS; e promoveu o fortalecimento Institucional da SESAB consolidando o papel de coordenador geral do Sistema Estadual de Saúde. Essas ações se deram por meio da construção e implantação de 10 Unidades Básicas de Saúde (UBS); 13 Policlínicas de Saúde; 14 Academias da Saúde; 09 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS); 01 Unidade de Acolhimento Infanto Juvenil (UAIJ); 01 Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST); construção do Hospital Metropolitano, ampliação e reforma do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS) e do Hospital João Batista Caribé que passou a se chamar Maternidade Maria Conceição de Jesus; superando os vazios assistenciais; além de promover o fortalecimento institucional através de capacitações para toda a rede SUS da RMS e gestores da SESAB.

Apesar do PROSUS ter promovido uma melhoria no SUS para a Região Metropolitana de Salvador, haja vista que se aponta avanços, como o aumento da população cadastrada no Programa de Saúde da Família (PSF); aumento da cobertura estimada do PSF; diminuição da Taxa de mortalidade prematura (30 a 69 anos) por Diabetes Mellitus e melhoria no acesso aos serviços de saúde, superando os vazios assistenciais, os desafios ainda permanecem. Os principais problemas de saúde devem ser resolvidos com a devida organização do SUS em Redes de Atenção à Saúde (RAS) coordenadas pela Atenção Primária à Saúde (APS). Avançar na definição de um modelo ideal que seja viável de ser colocado em prática e, diante disso, é importante dar continuidade às ações do PROSUS, através do PROSUS 2, para avançar nas mudanças necessárias que levem à conformação de um sistema integrado que opere de forma contínua e proativa e que seja capaz de responder, com eficiência, efetividade, qualidade e de modo equilibrado, às condições agudas e crônicas da população. Adequado para a atual situação epidemiológica e demográfica do estado.

**2.9. Projeto/Abrangência Geográfica**

**Abrangência Geográfica:** Estadual/Sem detalhes

| |
|---|
| Estado da Bahia () |

**2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO**

Devido às necessidades e desafios de saúde pública aqui apresentadas pelo estado da Bahia, a possibilidade de um financiamento externo pode garantir a manutenção e ampliar o acesso à saúde de qualidade, como também mitigar dificuldades econômicas a serem enfrentadas pelo contexto atual.

Considerando que o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) tem tradição na oferta a países da América Latina e Caribe a possibilidade de financiamento para melhoria da atenção à saúde das populações, o estado da Bahia oferece este pleito, como uma estratégia para a continuidade da melhoria do SUS Bahia.

O valor proposto do empréstimo é de US$ 150.000.000,00 com contrapartida do estado da Bahia de US$37.500.000,00.

Este projeto seguirá os Termos e Condições Financeiras Aplicáveis aos Empréstimos de Investimento com Recursos do Capital Ordinário do BID, sendo:

Carência: 5,5 anos (66 meses)

Prazo de amortização: 25 anos (máximo)

Vida Média Ponderada (VMP): 15,25 anos (máximo)

Total da taxa de juros: 2.75 % a.a. (vigente 1º trimestre de 2020)

Libor (3 meses): 1.83% (vigente 1º trimestre de 2020)

Margem do Fundo: 0.12% (vigente 1º trimestre de 2020)

Margem do empréstimo: 0.80% (vigente 1º trimestre de 2020)

Comissão de Crédito sobre o saldo não desembolsado do financiamento: 0.5% a.a. (vigente), não podendo ultrapassar 0.75% a.a.

Período para amortização e Vida Média Ponderada (VMP): O vencimento de empréstimos de investimento é de no máximo 25 anos e a vida média ponderada máxima de no máximo 15,25 anos.

Períodos de Desembolso e Carência: Os empréstimos standard têm um cronograma de amortização linear, com prestações semestrais ( ou trimestrais), consecutivas e na medida do possível iguais. Considerando que o período para desembolsos típico é de 5 anos contados da data de vigência do contrato de empréstimo, o período de carência típico é de 66 meses.

Taxas de juros: As taxas de juros estão baseadas na LIBOR (três meses), acrescidos dos encargos correspondentes (para a lista completa de taxas de juros e comissões aplicáveis aos produtos vigentes -capital ordinário, visite: https://www.iadb.org/en/idb-finance/interest-rates-and-loan-charges.

Moeda de referência: A moeda na qual se pretende contratar o empréstimo ora pretendido é o dólar americano, considerando a cotação do câmbio de fechamento de venda, em 07/06/2021, de R$/US$ 5,04 (U$$ 1,00=R$ 5,04), conforme informação do BACEN.

Justificativas para a Solicitação de Operação de Crédito Externo

O financiamento externo é um instrumento que possibilita apoio à realização de investimentos em políticas públicas, necessários à melhoria do acesso a serviços públicos de qualidade e indispensáveis para garantir o atendimento universal à saúde.

Partindo deste cenário que impõe novos e grandes desafios como o aumento exponencial de gastos no setor e das limitações impostas pelo orçamento da saúde, a utilização de fonte externa de financiamento representa a possibilidade de realizar investimentos estruturais no Sistema Único de Saúde no estado, objetivando o aperfeiçoamento, a revitalização e a consolidação do SUS no estado da Bahia.

O "Programa de Fortalecimento do SUS no Estado da Bahia ? PROSUS II?, projeto de investimento com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), pretende contribuir para suprir as deficiências já diagnosticadas no âmbito da saúde favorecendo a consolidação da reforma sanitária no estado, garantindo o acesso e a qualificação da assistência, por meio do fortalecimento da gestão do SUS e a estruturação dos serviços na rede estadual de saúde.

Este projeto inovará e fortalecerá a gestão do SUS Bahia de forma a garantir a integralidade da atenção. Sendo necessário para tal, a elaboração de um projeto consistente de implementação de tecnologia da informação, com o olhar de gestão, logística, recursos humanos e modernização do parque tecnológico da SES e seus serviços. Bem como o desenvolvimento e implementação de um sistema de informação que sirva de base para construção de indicadores com estabelecimentos de metas.

A fonte de recursos externos também representa maior segurança para a execução das políticas públicas, tendo em conta que os imprevistos gerados por contingenciamentos orçamentário e financeiros causam, muitas vezes, interrupções e atrasos que impedem o pleno alcance das metas.

A boa execução de outras experiências com uso de recursos de financiamento externo, mesmo atravessando mudanças políticas e gerenciais, demonstra a importância desta fonte como mecanismo de continuidade das ações planejadas.

Além disso, a complexidade do projeto requer um volume significativo de recursos não disponíveis no PPA do estado para investimentos em saúde, isso requer captação de recursos externos à Bahia. A opção por empréstimo externo se dá pelas taxas mais favoráveis oferecidas por organismos multilaterais.

Justificativa para Escolha da Fonte Externa

A decisão de buscar financiamento junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) decorre principalmente do reconhecimento da expertise do Banco em financiar grandes projetos com finalidades similares, tanto no Brasil quanto nos demais países membros. Na atualidade, o BID é a principal fonte de financiamento multilateral para o desenvolvimento econômico, social e institucional da América Latina e do Caribe e para a integração regional. Na área de políticas integradas de saúde, o BID financia atualmente a execução de 50 projetos em toda América Latina e Caribe. É importante destacar que o Banco inclui prioridade específica para a região Norte e Nordeste em seus indicadores de progresso na área de políticas de saúde.

Além disso, o Governo do Estado da Bahia compartilha do entendimento do BID de que as ações de cooperação técnica, consultoria, doações, financiamentos, assistência técnica e pesquisas devem ser realizadas de forma sustentável. Considera, ainda, que essas ações estão relacionadas a um amplo leque de possibilidades que, se integradas, potencializam o alcance dos objetivos propostos. Portanto, o valor agregado pelo Banco, além da contribuição financeira, em todas as fases dos programas ou projetos, inclui também ênfase nas ações de sustentabilidade institucional. O fortalecimento da qualidade da gestão também parece ser um dos objetos de preocupação e estratégias do BID, o que reforça a escolha da fonte externa de financiamento. Somado a isso, comparativamente ao mercado interno, as condições oferecidas pelo BID mostram-se atrativas, especialmente quanto à taxa de juros.

O BID, em sua trajetória, vem demonstrando possuir um importante valor agregado no apoio ao desenvolvimento e fortalecimento do Sistema Único de Saúde, permitindo a criação de instrumentos, metodologias e estudos, conforme foi vivenciado pelo O "Programa de Fortalecimento do SUS no Estado da Bahia  PROSUS I, o que possibilitará com este novo empréstimo o alcance de avanços importantes para o estado da Bahia.

**2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO**

Os beneficiários últimos das ações propostas nesta Carta Consulta são todos os cidadãos do estado da Bahia.

Em algumas das ações sugeridas, os próprios cidadãos também são o seu público-alvo. Em outras ações, o público-alvo são os profissionais e gestores da saúde, beneficiando indiretamente a população.

A população de baixa renda e vulneráveis nas regiões de intervenção do Programa se beneficiam das novas infraestruturas e/ou equipamentos sociais.

A criação de novos Centros de Especialidade em Reabilitação atenderão à minorias sociais. A implantação de novos Centros Especializados em Reabilitação possibilitará o acesso das pessoas com deficiências - temporárias ou permanentes - a reabilitação  e o cuidado multiprofissional em locais mais próximo das suas residências, impactando na qualidade da vida dessa população, historicamente excluída, e de suas famílias.

A ampliação de CAPS, principalmente tipologia III que acolhe noturnamente os usuários e as Unidades de Acolhimento (UA) que oferecem cuidados contínuos de saúde, com funcionamento de vinte e quatro horas, em ambiente residencial, para pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras serão estratégias fundamentais para a efetivação da mudança de modelo assistencial no estado e redução de judicializações.

Por fim, os investimentos em ações para desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica, como prontuários eletrônicos, conectividade nas Unidades de Saúde, certificações digitais, entre outros, promoverão a melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos e de gestão.

Em algumas das ações sugeridas, os próprios cidadãos também são o seu público-alvo. Em outras ações, o público-alvo são os profissionais e gestores da saúde, beneficiando indiretamente a população.

**2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO**

Sim

## 3. Financiamento

**3.1. Financiamento/Fonte**

**Moeda de Referência:** Dólar

| Fontes Internas | Sigla | Moeda | Valor Proposto | Taxa de Câmbio | Valor de Referência US $ |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrapartida Financeira | CF | US$ | 37.500.000,00 | 1,00 | 37.500.000,00 |
| **Fontes Externas** | **Sigla** | **Moeda** | **Valor Proposto** | **Taxa de Câmbio** | **Valor de Referência US $** |
| Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID | BID | US$ | 150.000.000,00 | 1,00 | 150.000.000,00 |
| Total: | | | 187.500.000,00 | | 187.500.000,00 |

**3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS**

Concordo

## 4. Execução

**4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL**

(i) Arranjo Institucional

O projeto será realizado pelo Governo do Estado da Bahia, através de sua Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (SESAB).

A secretaria formalizará, uma Unidade de Gestão do Projeto (UGP), que servirá como órgão de ligação entre a SESAB, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e outras organizações participantes.

(ii) Matriz de Responsabilidade

Vide Anexo 3- Matriz de Responsabilidade.

(iii) Arranjo Operacional

O Arranjo operacional deste programa contará com a equipe da SESAB com experiência prévia na execução de projetos com organismos internacionais, como foi o caso recente do PROSUS I.

Uma unidade de gerenciamento do programa está prevista, onde uma equipe de apoio adicional a equipe da SESAB será contratada para auxiliar no planejamento, execução e monitoramento do Programa.

### 4.2. Execução/Executores

| | | | |
|---|---|---|---|
| Executor: | Secretaria de Saúde do Estado da Bahia | | |
| Representante Oficial: | | | |
| Endereço da Sede: | | | |
| E-mail Institucional: | | | |
| Telefone: | | Fax: | |
| CNPJ: | | UF: | |

### 4.3. Execução/Prazo

**Prazo de Desembolso:** 5 **Anos**

### 4.4. Execução/Cronograma

| COMPONENTES | VALOR CUSTO | Ano 1 FONTES CF | Ano 1 FONTES BID | TOTAL CF | TOTAL BID |
|---|---|---|---|---|---|
| **C - AMPLIAÇÃO DO ACESSO E DA RESOLUTIVIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA** | **48.500.000,00** | **0,00** | **462.000,00** | | |
| S - AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE NO ESTADO | 44.700.000,00 | 0,00 | 362.000,00 | | |
| P - Construção de Unidades Básicas de Saúde (UBS) | 40.000.000,00 | 0,00 | 360.000,00 | | |
| P - Aquisição de Equipamentos de TIC, mobiliario e demais bens necessários para as UBS | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Equipamentos para implantação de 200 salas de pé diabético | 200.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | | |
| S - INVESTIMENTO TECNOLÓGICO NA ATENÇÃO BÁSICA | 3.800.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | | |
| P - Apoio a implantação do Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) nas unidades | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Finalização da implementação do Centralizador e transferência de tecnologia para utilização futura da REDS - Rede estadual de dados em saúde (barramento de serviços do estado) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Evolução e sustentação da REDS | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Aquisição de equipamentos para telediagnóstico na Atenção Básica | 1.000.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | | |
| P - Capacitações de curta duração para agregar e qualificar práticas e serviços | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **C - DESCENTRALIZAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE** | **114.700.000,00** | **4.000.000,00** | **2.992.000,00** | | |
| S - FORTALECIMENTO DE SERVIÇOS DA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE | 107.100.000,00 | 4.000.000,00 | 2.392.000,00 | | |
| P - Construção de 03 Policlínicas regionais de saúde | 7.400.000,00 | 0,00 | 592.000,00 | | |
| P - Funcionamento de 18 policlínicas no Estado da Bahia | 17.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Funcionamento do Hospital Metropolitano | 20.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | | |
| P - Aquisição de Equipamentos Policlínicas | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Reforma, Ampliação do Hospital Geral Ernesto Simões | 5.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Reforma e requalificação de estruturas descentralizadas de gestão do estado | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Aquisição de equipamentos para Núcleos Regionais e Rede de Frios | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Ampliação do número de leitos em Unidades de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Construção de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) | 7.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Aquisição de Equipamentos dos CAPS | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Construção de Unidades de Acolhimento (UA) | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Aquisição de Equipamentos das Unidades de Acolhimento (UA) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Construção de Centros Especializados de Reabilitação (CER) | 18.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Aquisição de Equipamentos CER | 11.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Aquisição de Hemóveis para Macrorregiões | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | | |
| S - APOIO AOS SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS DA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE | 7.600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | | |
| P - Aquisição de Carretas de Exames de Mamografia | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | | |
| P - Reforma e ampliação do Laboratório Central do Estado (LACEN) | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Construção de Laboratórios Regionais (LACEN) | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Aquisição de equipamentos para Laboratórios do Estado | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **C - FORTALECIMENTO DA GESTÃO, QUALIDADE E EFICIÊNCIA DA REDE SUS BAHIA** | **14.900.000,00** | **0,00** | **85.000,00** | | |
| S - AMPLIAÇÃO DA EFICIÊNCIA E QUALIDADE DA REDE HOSPITALAR | 3.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Certificação e acreditação dos hospitais e policlínicas sob gestão ou consorciadas com o estado | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Certificado Digital para as equipes da rede hospitalar | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Gestão e controle de acesso na rede hospitalar (Interoperabilidade com prontuário eletrônico) | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E DA GESTÃO DA REDE SUS BAHIA | 11.000.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | | |
| P - Ampliação para implantação do Prontuário Eletrônico na Rede SUS (SESAB | 1.500.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | | |
| P - Dimensionamento da Força de Trabalho | 500.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | | |
| P - Ampliação e Qualificação de Telessaúde e Telemedicina, incluindo Teleconsultas p/ Urgências , Telelaudos para Telediagnóstico, Telerregulação ambulatorial especializada, Teleconsultas para APS e Teleconsultoria. | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **C - GESTÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO - UNIDADE GESTORA DO PROGRAMA (UGP)** | **9.400.000,00** | **0,00** | **940.000,00** | | |
| S - GESTÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO | 9.400.000,00 | 0,00 | 940.000,00 | | |
| P - Implantação de uma Unidade Gestora do Programa e de Supervisão de obras | 7.400.000,00 | 0,00 | 740.000,00 | | |
| P - Contratação de empresa para desenvolver os Projetos Executivos | 1.000.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | | |
| P - Estudos de avaliação de médio prazo e de impacto | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| **Total** | **0,00** | **4.000.000,00** | **4.479.000,00** | **0,00** | **0,00** |

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

| COMPONENTES | VALOR CUSTO | Ano 2 FONTES CF | Ano 2 FONTES BID | TOTAL CF | TOTAL BID |
|---|---|---|---|---|---|
| **C - AMPLIAÇÃO DO ACESSO E DA RESOLUTIVIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA** | | **0,00** | **7.502.000,00** | | |
| S - AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE NO ESTADO | | 0,00 | 6.590.000,00 | | |
| P - Construção de Unidades Básicas de Saúde (UBS) | | 0,00 | 5.840.000,00 | | |
| P - Aquisição de Equipamentos de TIC, mobiliario e demais bens necessários para as UBS | | 0,00 | 720.000,00 | | |
| P - Equipamentos para implantação de 200 salas de pé diabético | | 0,00 | 30.000,00 | | |
| S - INVESTIMENTO TECNOLÓGICO NA ATENÇÃO BÁSICA | | 0,00 | 912.000,00 | | |
| P - Apoio a implantação do Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) nas unidades | | 0,00 | 140.000,00 | | |
| P - Finalização da implementação do Centralizador e transferência de tecnologia para utilização futura da REDS - Rede estadual de dados em saúde (barramento de serviços do estado) | | 0,00 | 40.000,00 | | |
| P - Evolução e sustentação da REDS | | 0,00 | 300.000,00 | | |
| P - Aquisição de equipamentos para telediagnóstico na Atenção Básica | | 0,00 | 400.000,00 | | |
| P - Capacitações de curta duração para agregar e qualificar práticas e serviços | | 0,00 | 32.000,00 | | |
| **C - DESCENTRALIZAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE** | | **8.375.000,00** | **6.625.000,00** | | |
| S - FORTALECIMENTO DE SERVIÇOS DA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE | | 8.375.000,00 | 6.275.000,00 | | |
| P - Construção de 03 Policlínicas regionais de saúde | | 0,00 | 1.480.000,00 | | |
| P - Funcionamento de 18 policlínicas no Estado da Bahia | | 4.375.000,00 | 0,00 | | |
| P - Funcionamento do Hospital Metropolitano | | 4.000.000,00 | 0,00 | | |
| P - Aquisição de Equipamentos Policlínicas | | 0,00 | 2.250.000,00 | | |
| P - Reforma, Ampliação do Hospital Geral Ernesto Simões | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Reforma e requalificação de estruturas descentralizadas de gestão do estado | | 0,00 | 525.000,00 | | |
| P - Aquisição de equipamentos para Núcleos Regionais e Rede de Frios | | 0,00 | 150.000,00 | | |
| P - Ampliação do número de leitos em Unidades de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva | | 0,00 | 450.000,00 | | |
| P - Construção de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) | | 0,00 | 390.000,00 | | |
| P - Aquisição de Equipamentos dos CAPS | | 0,00 | 40.000,00 | | |
| P - Construção de Unidades de Acolhimento (UA) | | 0,00 | 80.000,00 | | |
| P - Aquisição de Equipamentos das Unidades de Acolhimento (UA) | | 0,00 | 10.000,00 | | |
| P - Construção de Centros Especializados de Reabilitação (CER) | | 0,00 | 900.000,00 | | |
| P - Aquisição de Equipamentos CER | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Aquisição de Hemóveis para Macrorregiões | | 0,00 | 0,00 | | |
| S - APOIO AOS SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS DA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE | | 0,00 | 350.000,00 | | |
| P - Aquisição de Carretas de Exames de Mamografia | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Reforma e ampliação do Laboratório Central do Estado (LACEN) | | 0,00 | 175.000,00 | | |
| P - Construção de Laboratórios Regionais (LACEN) | | 0,00 | 100.000,00 | | |
| P - Aquisição de equipamentos para Laboratórios do Estado | | 0,00 | 75.000,00 | | |
| **C - FORTALECIMENTO DA GESTÃO, QUALIDADE E EFICIÊNCIA DA REDE SUS BAHIA** | | **0,00** | **2.155.000,00** | | |
| S - AMPLIAÇÃO DA EFICIÊNCIA E QUALIDADE DA REDE HOSPITALAR | | 0,00 | 580.000,00 | | |
| P - Certificação e acreditação dos hospitais e policlínicas sob gestão ou consorciadas com o estado | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Certificado Digital para as equipes da rede hospitalar | | 0,00 | 180.000,00 | | |
| P - Gestão e controle de acesso na rede hospitalar (Interoperabilidade com prontuário eletrônico) | | 0,00 | 400.000,00 | | |
| S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E DA GESTÃO DA REDE SUS BAHIA | | 0,00 | 1.575.000,00 | | |
| P - Ampliação para implantação do Prontuário Eletrônico na Rede SUS (SESAB | | 0,00 | 375.000,00 | | |
| P - Dimensionamento da Força de Trabalho | | 0,00 | 300.000,00 | | |
| P - Ampliação e Qualificação de Telessaúde e Telemedicina, incluindo Teleconsultas p/ Urgências , Telelaudos para Telediagnóstico, Telerregulação ambulatorial especializada, Teleconsultas para APS e Teleconsultoria. | | 0,00 | 900.000,00 | | |
| **C - GESTÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO - UNIDADE GESTORA DO PROGRAMA (UGP)** | | **0,00** | **1.965.000,00** | | |
| S - GESTÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO | | 0,00 | 1.965.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| P - Implantação de uma Unidade Gestora do Programa e de Supervisão de obras | | 0,00 | 1.665.000,00 | | |
| P - Contratação de empresa para desenvolver os Projetos Executivos | | 0,00 | 200.000,00 | | |
| P - Estudos de avaliação de médio prazo e de impacto | | 0,00 | 100.000,00 | | |
| **Total** | **0,00** | **8.375.000,00** | **18.247.000,00** | **0,00** | **0,00** |

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

| COMPONENTES | VALOR CUSTO | Ano 3 FONTES CF | Ano 3 FONTES BID | TOTAL CF | TOTAL BID |
|---|---|---|---|---|---|
| **C - AMPLIAÇÃO DO ACESSO E DA RESOLUTIVIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA** | | **0,00** | **18.830.000,00** | | |
| S - AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE NO ESTADO | | 0,00 | 17.370.000,00 | | |
| P - Construção de Unidades Básicas de Saúde (UBS) | | 0,00 | 15.490.000,00 | | |
| P - Aquisição de Equipamentos de TIC, mobiliario e demais bens necessários para as UBS | | 0,00 | 1.800.000,00 | | |
| P - Equipamentos para implantação de 200 salas de pé diabético | | 0,00 | 80.000,00 | | |
| S - INVESTIMENTO TECNOLÓGICO NA ATENÇÃO BÁSICA | | 0,00 | 1.460.000,00 | | |
| P - Apoio a implantação do Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) nas unidades | | 0,00 | 245.000,00 | | |
| P - Finalização da implementação do Centralizador e transferência de tecnologia para utilização futura da REDS - Rede estadual de dados em saúde (barramento de serviços do estado) | | 0,00 | 70.000,00 | | |
| P - Evolução e sustentação da REDS | | 0,00 | 525.000,00 | | |
| P - Aquisição de equipamentos para telediagnóstico na Atenção Básica | | 0,00 | 500.000,00 | | |
| P - Capacitações de curta duração para agregar e qualificar práticas e serviços | | 0,00 | 120.000,00 | | |
| **C - DESCENTRALIZAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE** | | **8.375.000,00** | **29.920.000,00** | | |
| S - FORTALECIMENTO DE SERVIÇOS DA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE | | 8.375.000,00 | 26.770.000,00 | | |
| P - Construção de 03 Policlínicas regionais de saúde | | 0,00 | 2.960.000,00 | | |
| P - Funcionamento de 18 policlínicas no Estado da Bahia | | 4.375.000,00 | 0,00 | | |
| P - Funcionamento do Hospital Metropolitano | | 4.000.000,00 | 0,00 | | |
| P - Aquisição de Equipamentos Policlínicas | | 0,00 | 2.625.000,00 | | |
| P - Reforma, Ampliação do Hospital Geral Ernesto Simões | | 0,00 | 1.650.000,00 | | |
| P - Reforma e requalificação de estruturas descentralizadas de gestão do estado | | 0,00 | 1.400.000,00 | | |
| P - Aquisição de equipamentos para Núcleos Regionais e Rede de Frios | | 0,00 | 400.000,00 | | |
| P - Ampliação do número de leitos em Unidades de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva | | 0,00 | 1.200.000,00 | | |
| P - Construção de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) | | 0,00 | 3.120.000,00 | | |
| P - Aquisição de Equipamentos dos CAPS | | 0,00 | 320.000,00 | | |
| P - Construção de Unidades de Acolhimento (UA) | | 0,00 | 640.000,00 | | |
| P - Aquisição de Equipamentos das Unidades de Acolhimento (UA) | | 0,00 | 80.000,00 | | |
| P - Construção de Centros Especializados de Reabilitação (CER) | | 0,00 | 7.200.000,00 | | |
| P - Aquisição de Equipamentos CER | | 0,00 | 5.175.000,00 | | |
| P - Aquisição de Hemóveis para Macrorregiões | | 0,00 | 0,00 | | |
| S - APOIO AOS SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS DA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE | | 0,00 | 3.150.000,00 | | |
| P - Aquisição de Carretas de Exames de Mamografia | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Reforma e ampliação do Laboratório Central do Estado (LACEN) | | 0,00 | 1.575.000,00 | | |
| P - Construção de Laboratórios Regionais (LACEN) | | 0,00 | 900.000,00 | | |
| P - Aquisição de equipamentos para Laboratórios do Estado | | 0,00 | 675.000,00 | | |
| **C - FORTALECIMENTO DA GESTÃO, QUALIDADE E EFICIÊNCIA DA REDE SUS BAHIA** | | **0,00** | **4.800.000,00** | | |
| S - AMPLIAÇÃO DA EFICIÊNCIA E QUALIDADE DA REDE HOSPITALAR | | 0,00 | 1.310.000,00 | | |
| P - Certificação e acreditação dos hospitais e policlínicas sob gestão ou consorciadas com o estado | | 0,00 | 150.000,00 | | |
| P - Certificado Digital para as equipes da rede hospitalar | | 0,00 | 360.000,00 | | |
| P - Gestão e controle de acesso na rede hospitalar (Interoperabilidade com prontuário eletrônico) | | 0,00 | 800.000,00 | | |
| S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E DA GESTÃO DA REDE SUS BAHIA | | 0,00 | 3.490.000,00 | | |
| P - Ampliação para implantação do Prontuário Eletrônico na Rede SUS (SESAB | | 0,00 | 600.000,00 | | |
| P - Dimensionamento da Força de Trabalho | | 0,00 | 190.000,00 | | |
| P - Ampliação e Qualificação de Telessaúde e Telemedicina, incluindo Teleconsultas p/ Urgências , Telelaudos para Telediagnóstico, Telerregulação ambulatorial especializada, Teleconsultas para APS e Teleconsultoria. | | 0,00 | 2.700.000,00 | | |
| **C - GESTÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO - UNIDADE GESTORA DO PROGRAMA (UGP)** | | **0,00** | **2.165.000,00** | | |
| S - GESTÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO | | 0,00 | 2.165.000,00 | | |
| P - Implantação de uma Unidade Gestora do Programa e de Supervisão de obras | | 0,00 | 1.665.000,00 | | |
| P - Contratação de empresa para desenvolver os Projetos Executivos | | 0,00 | 200.000,00 | | |
| P - Estudos de avaliação de médio prazo e de impacto | | 0,00 | 300.000,00 | | |
| **Total** | **0,00** | **8.375.000,00** | **55.715.000,00** | **0,00** | **0,00** |

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

| COMPONENTES | VALOR CUSTO | Ano 4 FONTES CF | Ano 4 FONTES BID | TOTAL CF | TOTAL BID |
|---|---|---|---|---|---|
| **C - AMPLIAÇÃO DO ACESSO E DA RESOLUTIVIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA** | | **0,00** | **17.237.000,00** | | |
| S - AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE NO ESTADO | | 0,00 | 16.245.000,00 | | |
| P - Construção de Unidades Básicas de Saúde (UBS) | | 0,00 | 14.600.000,00 | | |
| P - Aquisição de Equipamentos de TIC, mobiliario e demais bens necessários para as UBS | | 0,00 | 1.575.000,00 | | |
| P - Equipamentos para implantação de 200 salas de pé diabético | | 0,00 | 70.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| S - INVESTIMENTO TECNOLÓGICO NA ATENÇÃO BÁSICA | | 0,00 | 992.000,00 | | |
| P - Apoio a implantação do Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) nas unidades | | 0,00 | 231.000,00 | | |
| P - Finalização da implementação do Centralizador e transferência de tecnologia para utilização futura da REDS - Rede estadual de dados em saúde (barramento de serviços do estado) | | 0,00 | 66.000,00 | | |
| P - Evolução e sustentação da REDS | | 0,00 | 495.000,00 | | |
| P - Aquisição de equipamentos para telediagnóstico na Atenção Básica | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Capacitações de curta duração para agregar e qualificar práticas e serviços | | 0,00 | 200.000,00 | | |
| **C - DESCENTRALIZAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE** | | **8.375.000,00** | **31.775.000,00** | | |
| S - FORTALECIMENTO DE SERVIÇOS DA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE | | 8.375.000,00 | 28.275.000,00 | | |
| P - Construção de 03 Policlínicas regionais de saúde | | 0,00 | 1.850.000,00 | | |
| P - Funcionamento de 18 policlínicas no Estado da Bahia | | 4.375.000,00 | 0,00 | | |
| P - Funcionamento do Hospital Metropolitano | | 4.000.000,00 | 0,00 | | |
| P - Aquisição de Equipamentos Policlínicas | | 0,00 | 1.500.000,00 | | |
| P - Reforma, Ampliação do Hospital Geral Ernesto Simões | | 0,00 | 2.750.000,00 | | |
| P - Reforma e requalificação de estruturas descentralizadas de gestão do estado | | 0,00 | 1.575.000,00 | | |
| P - Aquisição de equipamentos para Núcleos Regionais e Rede de Frios | | 0,00 | 450.000,00 | | |
| P - Ampliação do número de leitos em Unidades de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva | | 0,00 | 1.350.000,00 | | |
| P - Construção de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) | | 0,00 | 3.540.000,00 | | |
| P - Aquisição de Equipamentos dos CAPS | | 0,00 | 440.000,00 | | |
| P - Construção de Unidades de Acolhimento (UA) | | 0,00 | 880.000,00 | | |
| P - Aquisição de Equipamentos das Unidades de Acolhimento (UA) | | 0,00 | 90.000,00 | | |
| P - Construção de Centros Especializados de Reabilitação (CER) | | 0,00 | 8.100.000,00 | | |
| P - Aquisição de Equipamentos CER | | 0,00 | 5.750.000,00 | | |
| P - Aquisição de Hemóveis para Macrorregiões | | 0,00 | 0,00 | | |
| S - APOIO AOS SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS DA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE | | 0,00 | 3.500.000,00 | | |
| P - Aquisição de Carretas de Exames de Mamografia | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Reforma e ampliação do Laboratório Central do Estado (LACEN) | | 0,00 | 1.750.000,00 | | |
| P - Construção de Laboratórios Regionais (LACEN) | | 0,00 | 1.000.000,00 | | |
| P - Aquisição de equipamentos para Laboratórios do Estado | | 0,00 | 750.000,00 | | |
| **C - FORTALECIMENTO DA GESTÃO, QUALIDADE E EFICIÊNCIA DA REDE SUS BAHIA** | | **0,00** | **6.260.000,00** | | |
| S - AMPLIAÇÃO DA EFICIÊNCIA E QUALIDADE DA REDE HOSPITALAR | | 0,00 | 1.460.000,00 | | |
| P - Certificação e acreditação dos hospitais e policlínicas sob gestão ou consorciadas com o estado | | 0,00 | 500.000,00 | | |
| P - Certificado Digital para as equipes da rede hospitalar | | 0,00 | 360.000,00 | | |
| P - Gestão e controle de acesso na rede hospitalar (Interoperabilidade com prontuário eletrônico) | | 0,00 | 600.000,00 | | |
| S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E DA GESTÃO DA REDE SUS BAHIA | | 0,00 | 4.800.000,00 | | |
| P - Ampliação para implantação do Prontuário Eletrônico na Rede SUS (SESAB | | 0,00 | 300.000,00 | | |
| P - Dimensionamento da Força de Trabalho | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Ampliação e Qualificação de Telessaúde e Telemedicina, incluindo Teleconsultas p/ Urgências , Telelaudos para Telediagnóstico, Telerregulação ambulatorial especializada, Teleconsultas para APS e Teleconsultoria. | | 0,00 | 4.500.000,00 | | |
| **C - GESTÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO - UNIDADE GESTORA DO PROGRAMA (UGP)** | | **0,00** | **2.165.000,00** | | |
| S - GESTÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO | | 0,00 | 2.165.000,00 | | |
| P - Implantação de uma Unidade Gestora do Programa e de Supervisão de obras | | 0,00 | 1.665.000,00 | | |
| P - Contratação de empresa para desenvolver os Projetos Executivos | | 0,00 | 200.000,00 | | |
| P - Estudos de avaliação de médio prazo e de impacto | | 0,00 | 300.000,00 | | |
| **Total** | **0,00** | **8.375.000,00** | **57.437.000,00** | **0,00** | **0,00** |

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

| COMPONENTES | VALOR CUSTO | Ano 5 FONTES CF | Ano 5 FONTES BID | TOTAL CF | TOTAL BID |
|---|---|---|---|---|---|
| **C - AMPLIAÇÃO DO ACESSO E DA RESOLUTIVIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA** | | **0,00** | **4.469.000,00** | **0,00** | **48.500.000,00** |
| S - AMPLIAÇÃO DA COBERTURA DA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE NO ESTADO | | 0,00 | 4.133.000,00 | 0,00 | 44.700.000,00 |
| P - Construção de Unidades Básicas de Saúde (UBS) | | 0,00 | 3.710.000,00 | 0,00 | 40.000.000,00 |
| P - Aquisição de Equipamentos de TIC, mobiliario e demais bens necessários para as UBS | | 0,00 | 405.000,00 | 0,00 | 4.500.000,00 |
| P - Equipamentos para implantação de 200 salas de pé diabético | | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| S - INVESTIMENTO TECNOLÓGICO NA ATENÇÃO BÁSICA | | 0,00 | 336.000,00 | 0,00 | 3.800.000,00 |
| P - Apoio a implantação do Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) nas unidades | | 0,00 | 84.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| P - Finalização da implementação do Centralizador e transferência de tecnologia para utilização futura da REDS - Rede estadual de dados em saúde (barramento de serviços do estado) | | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| P - Evolução e sustentação da REDS | | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| P - Aquisição de equipamentos para telediagnóstico na Atenção Básica | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| P - Capacitações de curta duração para agregar e qualificar práticas e serviços | | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| **C - DESCENTRALIZAÇÃO E REGIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE** | | **8.375.000,00** | **5.888.000,00** | **37.500.000,00** | **77.200.000,00** |
| S - FORTALECIMENTO DE SERVIÇOS DA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE | | 8.375.000,00 | 5.888.000,00 | 37.500.000,00 | 69.600.000,00 |
| P - Construção de 03 Policlínicas regionais de saúde | | 0,00 | 518.000,00 | 0,00 | 7.400.000,00 |
| P - Funcionamento de 18 policlínicas no Estado da Bahia | | 4.375.000,00 | 0,00 | 17.500.000,00 | 0,00 |
| P - Funcionamento do Hospital Metropolitano | | 4.000.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 |
| P - Aquisição de Equipamentos Policlínicas | | 0,00 | 1.125.000,00 | 0,00 | 7.500.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| P - Reforma, Ampliação do Hospital Geral Ernesto Simões | | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 5.500.000,00 |
| P - Reforma e requalificação de estruturas descentralizadas de gestão do estado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 |
| P - Aquisição de equipamentos para Núcleos Regionais e Rede de Frios | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| P - Ampliação do número de leitos em Unidades de Terapia Intensiva e Semi-Intensiva | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| P - Construção de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) | | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 7.800.000,00 |
| P - Aquisição de Equipamentos dos CAPS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| P - Construção de Unidades de Acolhimento (UA) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 |
| P - Aquisição de Equipamentos das Unidades de Acolhimento (UA) | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| P - Construção de Centros Especializados de Reabilitação (CER) | | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 18.000.000,00 |
| P - Aquisição de Equipamentos CER | | 0,00 | 575.000,00 | 0,00 | 11.500.000,00 |
| P - Aquisição de Hemóveis para Macrorregiões | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| S - APOIO AOS SERVIÇOS DIAGNÓSTICOS DA REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600.000,00 |
| P - Aquisição de Carretas de Exames de Mamografia | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| P - Reforma e ampliação do Laboratório Central do Estado (LACEN) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 |
| P - Construção de Laboratórios Regionais (LACEN) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| P - Aquisição de equipamentos para Laboratórios do Estado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| **C - FORTALECIMENTO DA GESTÃO, QUALIDADE E EFICIÊNCIA DA REDE SUS BAHIA** | | **0,00** | **1.600.000,00** | **0,00** | **14.900.000,00** |
| S - AMPLIAÇÃO DA EFICIÊNCIA E QUALIDADE DA REDE HOSPITALAR | | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 3.900.000,00 |
| P - Certificação e acreditação dos hospitais e policlínicas sob gestão ou consorciadas com o estado | | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| P - Certificado Digital para as equipes da rede hospitalar | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 |
| P - Gestão e controle de acesso na rede hospitalar (Interoperabilidade com prontuário eletrônico) | | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E DA GESTÃO DA REDE SUS BAHIA | | 0,00 | 1.050.000,00 | 0,00 | 11.000.000,00 |
| P - Ampliação para implantação do Prontuário Eletrônico na Rede SUS (SESAB | | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| P - Dimensionamento da Força de Trabalho | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| P - Ampliação e Qualificação de Telessaúde e Telemedicina, incluindo Teleconsultas p/ Urgências , Telelaudos para Telediagnóstico, Telerregulação ambulatorial especializada, Teleconsultas para APS e Teleconsultoria. | | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 9.000.000,00 |
| **C - GESTÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO - UNIDADE GESTORA DO PROGRAMA (UGP)** | | **0,00** | **2.165.000,00** | **0,00** | **9.400.000,00** |
| S - GESTÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO | | 0,00 | 2.165.000,00 | 0,00 | 9.400.000,00 |
| P - Implantação de uma Unidade Gestora do Programa e de Supervisão de obras | | 0,00 | 1.665.000,00 | 0,00 | 7.400.000,00 |
| P - Contratação de empresa para desenvolver os Projetos Executivos | | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| P - Estudos de avaliação de médio prazo e de impacto | | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| **Total** | **187.500.000,00** | **8.375.000,00** | **14.122.000,00** | **37.500.000,00** | **150.000.000,00** |

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

## 5. Riscos

### 5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

Para que seja iniciada a implementação do Programa, deverá ser elaborada e submetidos à Assembleia Legislativa Lei autorizativa para obtenção de empréstimo.

### 5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

A manutenção dos novos serviços são viabilizados pela Política Nacional de Atenção Básica, Politica de Vigilância na Saúde, Política Nacional de Saúde Mental e MAC, com financiamento tripartite.

Os recursos para contratações dos serviços que serão implantados, como Unidades Básicas de Saúde são viabilizados pela Política Nacional de Atenção Básica e o Incentivo Financeiro Estadual para a Estratégia de Estruturação da Rede de Atenção à Saúde, bem como os Serviços de Reabilitação e Atenção Psicossocial recebem financiamento das Políticas Respectivas constantes na Portaria de Consolidação nº 6 de 28 de setembro de 2017.

Já as Policlínicas Regionais de Saúde, estas fazem parte do Consórcio Inter federativo de Saúde, o qual o Estado faz parte e rateia 40 % do custeio dos Serviços.

Quanto aos serviços relativos ao Telessaúde, vale ressaltar que o Estado da Bahia possui o Núcleo Técnico Científico funcionando desde 2013, com profissionais do próprio quadro de Servidores Estatutários, complementado com servidores do quadro da Fundação Estatal Saúde da Família, mediante Contrato de Programa.

### 5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

Para a realização deste Programa não estão previstas desapropriações ou indenizações para as construções que serão construídas em terrenos públicos, municipal ou estadual.

**5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS**

Os possíveis impactos ambientais decorrentes que este Programa possa vir a apresentar serão minimizados projetos, ações e mecanismos voltados para a proteção do meio ambiente, para a redução ou para a mitigação de impactos ambientais que poderão ocorrer durante as intervenções, em conformidade com o Decreto Estadual n° 14.024 de 06 de junho de 2012.A aplicação da legislação ambiental pertinente visa assegurar que os investimentos sejam ambientalmente e socialmente sustentáveis, e que, dessa forma, possam contribuir para atingir os objetivos do Programa e assim, os níveis esperados de eficácia, eficiência e efetividade dos projetos financiados.

As novas construções e reformas serão minimizadas e/ou compensadas através do emprego de técnicas apropriadas e da utilização do conceito de edifício sustentável. Além disso, é importante sinalizar que todos os projetos de construção ou ampliação de unidades de saúde devem ser acompanhados de projetos de gerenciamento de resíduos de saúde. Adiciona-se a isso o fato de que os recursos serão investidos em unidades de saúde que tem baixo perfil poluidor.

**5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL**

Não existe um impacto social do Programa que possa interferir negativamente na saúde da população do estado, muito menos em populações vulneráveis como populações indígenas, quilombolas, entre outras.

O impacto social é positivo, na medida que qualifica a oferta de atendimento mais próximo das pessoas, além de gerar, em cada obra construída emprego e renda e, nos novos serviços implantados, oportunidades de emprego e renda.

**5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS**

Para a realização deste Programa não serão necessários reassentamentos.

**5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN**

---

**Informações relevantes**

- 13/12/2022: O pleito relativo ao "Programa de Fortalecimento do SUS no Estado da Bahia - PROSUS II" foi retirado de pauta na 161ª Reunião da Comissão de Financiamentos Externos (COFIEX), realizada em 25 de outubro de 2022, a pedido do Estado por meio do Ofício GAB nº172/2022, de 20 de outubro de 2022. O pleito será reapreciado na próxima reunião de deliberação.